



Inkoopbeleid Wlz Gehandicaptenzorg 2027-2029

Versie: 1.0

Datum: 1 juni 2026

Wat leest u in dit inkoopbeleid?

1. Wat willen we bereiken?	3
2. Bouwen aan de beweging 'Van Zorg naar Gewoon Leven'	5
3. Samenwerken aan een stevige regionale basis	9
4. Voldoende expertise en aanbod voor complexe zorg	13
5. Tarieven en volumes	15
6. Aanvullende thema's op het inkoopbeleid	19
7. Planning en termijnen	26
8. Inkoopprocedure	27
9. Verantwoording, sturing en nacalculatie	37
Bijlagen	40

1. Wat willen we bereiken?

Lees in dit hoofdstuk over de kern van ons inkoopbeleid. En wat we met het inkoopbeleid willen bereiken.

1.1 De toekomst: we hebben elkaar nodig.

Om te komen tot dit inkoopbeleid gingen we in gesprek met klanten en hun naasten, maar ook bestuurders en beleidsmakers in de gehandicaptenzorg. Samen met hen bespraken we welke belangrijke onderwerpen zij zien voor de gehandicaptenzorg in de toekomst. Deze gehandicaptenzorg vraagt om andere keuzes en meer samenwerking.

Uit de gesprekken komt een duidelijk beeld naar voren. Klanten willen meedoen in de samenleving en erbij horen. Dat kan alleen samen met naasten, medewerkers, buurtbewoners en lokale ondernemers. Tegelijkertijd staat de zorg onder druk door personeelstekorten. Door vergrijzing, uitstroom en strengere regels voor zzp'ers zijn er minder medewerkers beschikbaar. Ook vinden veel mensen het werk zwaar en zijn medewerkers met specifieke deskundigheid schaars.

De zorgvraag wordt groter en complexer. Klanten worden ouder en hebben vaker meerdere zorgvragen. Er is meer instroom vanuit de jeugdzorg, zoals mensen met een lichte verstandelijke beperking. Ook groeit de groep met moeilijk verstaanbaar gedrag. Voor deze groep loopt de zorg soms vast en is het lastig om een passende oplossing te vinden. Dit vraagt om betere doorstroom in de keten en vooral om intensieve samenwerking. Zodat niemand tussen wal en schip valt.

De uitdagingen zijn te groot voor één organisatie. Daarom is samenwerking en de kracht van het collectief essentieel. Zorgaanbieders zullen steeds meer moeten optreden als maatschappelijke partners die over hun eigen grenzen heen kijken. Zo versterken we elkaar op de thema's waarin we elkaar nodig hebben.

1.2 De 3 inkoopdoelen van het inkoopbeleid.

De inzichten uit de gesprekken gebruikten we bij het maken van ons inkoopbeleid. In dit beleid werken we met 3 inkoopdoelen. We willen dat mensen de juiste zorg krijgen, op de juiste plek. Het liefst midden in de samenleving, als dat kan. En beschermd, als dat nodig is.

De 3 inkoopdoelen horen bij elkaar. Waar ruimte ontstaat, is deze ook weer nodig. Zo zorgen we samen voor een goede doorstroom in de zorg. Bij elk inkoopdoel maken we gebruik van de kansen die innovatie biedt. Zo kunnen we de zorg slimmer en beter organiseren. Ook doelmatigheid is belangrijk. We letten goed op dat we de mensen en middelen die er zijn effectief en zorgvuldig inzetten.

Samenwerking is bij elk inkoopdoel heel belangrijk. Die samenwerking gaat verder dan wat we nu al gewend zijn en speelt zich af op meerdere niveaus. Samen rondom de klant, waarin ook naasten en de buurt een rol kunnen spelen. Samen in de regio met andere zorgaanbieders én over de grenzen van sectoren heen, zoals met de GGZ of andere wettelijke domeinen. Zo werken we samen aan sterke en toekomstbestendige gehandicaptenzorg.

1. Bouwen aan de beweging 'Van Zorg naar Gewoon Leven'.

Mensen met een beperking willen meedoen en gezien worden. Zij willen zijn wie zij zijn en een bijdrage leveren, net als ieder ander. De mens staat centraal, niet de beperking. We kijken naar wat iemand kan en belangrijk vindt. We nemen niet over wat iemand zelf kan. We ondersteunen waar dat nodig is. Het gewone leven is het uitgangspunt. Daar horen werken, hobby's, samenleven en het benutten van talenten bij. De beweging 'Van Zorg naar Gewoon Leven' ondersteunt dit. Meedoen in de samenleving is daarbij het uitgangspunt. Zoals wonen op een eigen plek, zo thuis als mogelijk. Zorgzame gemeenschappen kunnen hier een positieve rol in spelen. Maar ook een zinvolle dag invulling draagt hieraan bij. Ook voor mensen met een complexere zorg- of begeleidingsvraag worden banden met de lokale gemeenschappen versterkt. Medewerkers 'zorgen met' in plaats van 'zorgen voor'. Lees alle beleidsthema's die horen bij de beweging ['Van Zorg naar Gewoon Leven'](#).

2. Samenwerken aan een stevige basis in de regio.

Zorgaanbieders, zorgkantoor en gemeenten werken samen aan een stevige basis voor zorg en essentiële voorzieningen in de regio. Samenwerking is onmisbaar om de gezamenlijke uitdagingen aan te pakken. Veel regio's werken hier al aan binnen het huidige inkoopbeleid. Vanuit die beweging gaan we nu een stap verder. Samenwerken in de regio hoort bij de opgave en is niet vrijblijvend. Elke regio maakt samen een duidelijke visie op de samenwerking en spreekt af wie welke rol heeft en hoe overleg en besluiten plaatsvinden. Deze afspraken leggen regio's vast in een gezamenlijke regionale overeenkomst. Daarbij gaat het onder andere om het samen beschikbaar houden van essentiële voorzieningen en het versterken van kennis en deskundigheid.

Ook gerichte afspraken over doorstroom horen bij deze regionale samenwerking. Goede doorstroom zorgt voor betere inzet van plekken en medewerkers. Door klanten in beeld te brengen die een stap naar zelfstandigheid kunnen zetten, ontstaat er ruimte voor mensen met een complexere zorgvraag. Dit vraagt om afspraken door de hele zorgketen heen en samenwerking vanuit regionaal perspectief. Lees meer over de thema's die vragen om [regionale samenwerking](#).

3. Organiseren van voldoende expertise en aanbod voor de complexe zorg.

We houden extra aandacht voor mensen met een complexe zorgvraag. Voor deze klanten loopt de zorg nu regelmatig vast, of is er geen passend aanbod. Dat vraagt om nieuwe oplossingen. Samen met u brengen we per regio in beeld welke woonplekken en voorzieningen nodig zijn. Zo zien we beter wat er ontbreekt en waar de knelpunten zitten. Met gerichte contractering versterken en vergroten we het aanbod, vooral voor de doelgroepen waarvoor nu te weinig passende zorg is.

Daarnaast werken we samen met regionale partners om oplossingen te vinden voor moeilijk plaatsbare klanten. Met duidelijke regionale samenwerkingsafspraken zorgen we ervoor dat deze mensen niet tussen wal en schip vallen. [Lees hoe wij dit willen doen](#).

2. Bouwen aan de beweging ‘Van Zorg naar Gewoon Leven’

Lees in dit hoofdstuk hoe wij invulling geven aan de beweging ‘Van Zorg naar Gewoon Leven’. En wat dit voor u betekent.

2.1 De beweging ‘Van Zorg naar Gewoon Leven’ is ons uitgangspunt.

Dit inkoopdoel gaat over de beweging ‘Van Zorg naar Gewoon Leven’. Mensen met een beperking willen meedoen en gezien worden. Zij willen zijn wie zij zijn en bijdragen, net als ieder ander. Het gewone leven is het uitgangspunt. Daar horen een eigen plek, werken, hobby’s, samenleven en het benutten van talenten bij. De beweging ‘Van Zorg naar Gewoon Leven’ ondersteunt dit. Wij willen dat klanten zo volwaardig mogelijk deelnemen aan de samenleving. Niet alleen als ontvanger van zorg, maar ook als betrokken en betekenisvolle buurtbewoner. Voor klanten die behoefte hebben aan meer beschutting en veiligheid geldt dat de samenleving welkom is om mee te doen.

De beweging ‘Van Zorg naar Gewoon Leven’ vraagt een andere manier van kijken. Kijken naar wat iemand zelf kan en wil. Daarna kijken welke ondersteuning daarbij past. Zo helpen we klanten om zo zelfstandig mogelijk te wonen en leven, met passende zorg dichtbij. Klanten ervaren meer eigen regie en kwaliteit van leven doordat zij keuzes maken over hun leven en zorg. Dit vraagt om investeren in extramurale zorg, passende woonvormen, zinvolle daginvulling en samenwerken in de regio. Ook met andere domeinen en met de wijk of buurt. Wij stimuleren deze beweging met duidelijke keuzes in ons inkoopbeleid.

2.2 We stimuleren de beweging naar zorg thuis.

Voor klanten in de gehandicaptenzorg streven we naar zorg, ‘zo thuis mogelijk’. We geloven dat dit bijdraagt aan een toekomstbestendig zorglandschap waarin de behoeften van klanten centraal staan. Klanten, voor wie dit passend is, willen we zo veel mogelijk in staat stellen om zelf en/of samen met naasten de regie te voeren. Ook nemen zij betekenisvol deel aan de samenleving en wonen zij zo zelfstandig mogelijk met passende ondersteuning. We verwachten van u dat u actief inzet op de volgende thema’s:

Thuis, tenzij voor de profielen 3VG, 4VG, 6VG, 2LG, 4LG, 5LG en 2ZGVis.

Voor de profielen 3VG, 4VG, 6VG, 2LG, 5LG en 2ZGVis zien we meer mogelijkheden om de zorg thuis te organiseren, via een Modulair Pakket Thuis (MPT) of een Volledig Pakket Thuis (VPT). Klanten met deze profielen kiezen nu al relatief vaak voor deze vormen van zorg. Ook zien we de afgelopen jaren steeds meer verschuiving van intramurale zorg naar MPT of VPT.

We vragen u om actief te kijken waar deze mogelijkheden liggen voor uw klanten. Voor nieuwe klanten is extramurale zorg bij deze profielen de voorkeursoptie bij instroom. Zorgaanbieders verkennen daarom eerst of een MPT of VPT passend is. Daarnaast vragen we om bestaande klanten opnieuw te beoordelen: welke klanten kunnen zelfstandig wonen met ondersteuning via MPT of VPT? Ook het omzetten van bestaande locaties naar VPT kan hieraan bijdragen.

Thuis is het uitgangspunt, intramuraal als het nodig is.

Als zorg thuis niet passend is of niet verantwoord kan worden gegeven, dan is zorg in een intramurale of geclusterde woonvorm altijd mogelijk. Wat iemand nodig heeft, staat hierbij centraal. De zorgvraag, de persoonlijke situatie, de omgeving en het beschikbare aanbod zijn daarbij belangrijk. Voor iedere klant wordt beoordeeld of zorg thuis mogelijk is via een MPT of VPT.

Is zorg thuis niet voldoende of te risicovol, dan blijft intramurale zorg een optie. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer continuïteit, veiligheid of intensieve begeleiding nodig is. Deze keuze maakt u altijd per klant en onderbouwt u in zijn of haar zorgplan. Daarbij gebruikt u het [afwegingskader](#) als hulpmiddel bij het gesprek en de beoordeling. Dit kader ondersteunt bij het wegen van omstandigheden.

2.3 MPT is voorliggend op (ongeclusterd) VPT.

Dit uitgangspunt helpt om zorg thuis passend en doelmatig te organiseren.

MPT is het uitgangspunt bij zorg thuis.

We verwachten dat zorgaanbieders zorg thuis in principe leveren met een MPT. Dit geldt nadrukkelijk voor nieuwe klanten met een 3VG, 4VG, 6VG, 2LG, 4LG, 5LG en 2ZGVis. Ook voor klanten die vanuit intramurale zorg doorstromen naar zorg thuis heeft MPT de voorkeur. MPT ondersteunt het scheiden van wonen en zorg. Past MPT niet, dan kan een VPT ingezet worden. Alleen als ook dat niet passend is, komt intramurale zorg in beeld. Zo organiseren we zorg stap voor stap, passend bij wat de klant nodig heeft.

We zetten ongeclusterd VPT om naar MPT.

We zien dat ongeclusterd VPT vaak wordt ingezet met een beperkte inzet van professionele zorg. In deze situaties is MPT doelmatiger. Daarom sturen we op het omzetten van ongeclusterd VPT naar MPT. Dit vraagt van u dat u kritisch kijkt naar de zorginzet en dit samen met de klant afweegt. Niet iedere klant kan deze overstap maken. Als de zorgvraag meer nabijheid en samenhang vraagt, kan VPT wel passend zijn. U gebruikt hierbij dit [afwegingskader](#) als hulpmiddel. Dit kader geeft richting wanneer VPT passend is, met ruimte voor maatwerk en professionele beoordeling.

2.4 Met een financiële bijdrage stimuleren we omzetting van intramuraal naar MPT of VPT.

We stimuleren zorgaanbieders om intramurale plekken om te zetten naar plekken waar zorg via MPT of VPT wordt geleverd. Tijdens meedenksessies voor het nieuwe inkoopbeleid gaven verschillende zorgaanbieders aan dat deze omzetting extra kosten met zich meebrengt. Daarom biedt dit beleid de mogelijkheid voor een financiële bijdrage aan deze omzetting. Voor toekenning van de financiële bijdrage gelden [voorwaarden](#). Wanneer uw project voldoet aan de voorwaarden, komt u in aanmerking voor een eenmalige financiële bijdrage van € 5.000 per klant. Hiermee dragen we bij aan het scheiden van wonen en zorg en het “thuis, tenzij” beleid.

2.5 Samen bouwen aan randvoorwaarden in de wijk.

Om meer zorg thuis mogelijk te maken, moeten de randvoorwaarden goed geregeld zijn. Denk aan voldoende en passende woningen, inzet van behandeling, dagbesteding en logeerszorg, en het gebruik van (zorg)technologie. Dit lukt alleen als we hier in de regio samen aan werken. Samenwerking is daarom essentieel.

Meer zorg thuis realiseren lukt niet door één partij alleen. We doen dit samen met zorgaanbieders, gemeenten en woningcorporaties. Hoe we deze samenwerking vormgeven, leest u bij het inkoopdoel [regionale samenwerking](#).

2.6 Zorgzame gemeenschappen voor duurzaam (zelfstandig) wonen.

Als onderdeel van de beweging ‘Van Zorg naar Gewoon Leven’ vinden wij het belangrijk om te werken aan zorgzame gemeenschappen. Dit zijn omgevingen waarin klanten, naasten, professionals, organisaties en inwoners van een dorp of wijk elkaar kennen en ondersteunen. Eenzaamheid en niet mee kunnen doen hebben een grote impact op klanten. Zonder een sociaal netwerk kan de druk op professionele zorg toenemen en neemt het risico op terugval en zwaardere zorg toe. Zorgzame gemeenschappen helpen klanten om beter mee te doen in het dagelijks leven. Dit is een bredere maatschappelijke beweging.

Klanten willen volwaardig meedoen in de samenleving. Dit vraagt om een beweging van binnen naar buiten. Klanten, professionals en organisaties zoeken actief contact met de buurt en sluiten aan bij bestaande initiatieven. Tegelijk is er ook een beweging van buiten naar binnen nodig: voor klanten die in een meer beschutte woonomgeving moeten wonen. De samenleving wordt uitgenodigd, ondersteund en gefaciliteerd om betrokken te zijn bij hun dagelijks leven. We nodigen u ook uit om hier actief in te investeren. Ook wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid door passende initiatieven te ondersteunen.

Waar mogelijk zetten we middelen voor DOS preventieve maatregelen in. Deze middelen helpen om de gezamenlijke kracht te versterken om zo te voorkomen dat zwaardere zorg nodig is. Meer informatie over deze middelen, de voorwaarden en de

procedure leest u in het inkoopbeleid DOS preventieve maatregelen¹. Dit inkoopbeleid publiceren we naar verwachting medio juni 2026 op onze website.

2.7 Samen werken we met de regionale routekaart aan meer woningaanbod.

We kampen in Nederland met een tekort aan woningen. Als onderdeel van de regionale opgave wordt in uw regio met een vertegenwoordiging van zorgaanbieders, de regionale routekaart GZ/GGZ uitgevoerd. De routekaart is een instrument waarmee u in de regio samen met gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders de woonvraag en knelpunten daarbij voor klanten inzichtelijk maakt. Deze inzichten zet u om in duidelijke uitvoeringsafspraken over de beschikbaarheid van passende woningen en zorgvastgoed. Zo ontstaat gezamenlijke urgentie en eigenaarschap. De woonvraag van GZ- en GGZ-klanten verbindt u structureel aan woonzorgvisies en uitvoeringsagenda's. Daarmee sturen we regionaal op voldoende en passende (extramurale) woonvormen. Dit helpt om vastgelopen doorstroming vanuit intramurale zorg te doorbreken en leidt tot concrete projecten met heldere afspraken over wat wordt gerealiseerd, voor wie en door wie. Dit sluit aan bij de te verwachten implementatie van de wet versterking regie volkshuisvesting. We stellen vanuit de [regionale middelen](#) een financiële bijdrage beschikbaar voor de uitvoering van de routekaart in de regio, mits cofinanciering door de zorgaanbieders plaats vindt.

2.8 Zinnvolle daginvulling en digitale dagbesteding.

Een betekenisvolle daginvulling is een belangrijk doel in de ondersteuning van mensen met een beperking. Een betekenisvolle daginvulling sluit zo veel mogelijk aan bij de samenleving. Dit is niet vanzelfsprekend voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. Daarom vraagt dit gerichte aandacht.

Meer participatie zorgt voor een waardevolle bijdrage.

Dat is goed voor henzelf én voor de samenleving. Deelname aan werk en dagbesteding vergroot de zichtbaarheid in de samenleving. Dit kan zorgen voor meer passende werkplekken en begrip in woonwijken. Tegelijk blijft een beschermde omgeving soms nodig. Niet voor iedereen past dagbesteding midden in de samenleving. Ook een beschermde plek kan bijdragen aan een betekenisvol leven. Activiteiten krijgen extra waarde als zij bijdragen aan de samenleving en aan het gevoel van eigenwaarde, bijvoorbeeld via arbeidsmatige activiteiten. Daarom verwachten wij dat u vanuit een duidelijke visie op participatie de dagbesteding zo organiseert dat integratie in de samenleving wordt vergroot.

Digitale dagbesteding is een waardevolle aanvulling.

Technologie maakt digitale dagbesteding mogelijk binnen het bestaande aanbod. Via technologie kunnen klanten vanuit huis meedoen aan activiteiten. Dit vervangt geen reguliere dagbesteding voor de klant, tenzij dat beter passend is, maar vult deze aan. U kunt beide vormen combineren. Digitale dagbesteding heeft voordelen voor zowel klanten als medewerkers. Het kan zorgen voor een efficiëntere inzet van dagbesteding, minder reistijd en lagere reiskosten. Ook verlaagt het de drempel om mee te doen, vooral voor klanten die zelfstandig wonen. Daarom verwachten we dat digitale dagbesteding een vast onderdeel is van uw visie.

Regionale samenwerking versterkt initiatieven voor participatie.

Via regionale afstemming verbinden en vergroten we het aantal initiatieven van dagbesteding in de samenleving. In elke regio is zicht op wat werkt. Ook spreken we een doel af om deze initiatieven uit te breiden. Elke regio breidt participatie ieder jaar verder uit.

Wetgeving sluit nog niet goed aan op deze ontwikkelingen.

We zien dat regels nu soms beperken. Daarom gaan wij hierover in gesprek met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Samen kijken we hoe de bekostiging flexibeler kan, zodat initiatieven in de samenleving ook passende (financiële) steun krijgen.

¹ Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft nog niet voor de hele beleidsperiode geld beschikbaar gesteld voor DOS Preventieve Maatregelen. Bij het maken van dit beleid gaan we er wel van uit dat dit alsnog gebeurt. Komt het geld er toch niet? Dan nemen we dit mee in een aanvulling op het inkoopbeleid van het betreffende jaar.

2.9 Team van de Toekomst.

We stimuleren zorg die klanten sterker maakt in eigen regie, samenredzaamheid en laat meedoen in de samenleving. Wij noemen dit het Team van de Toekomst. We werken daarmee toe naar meer autonomie, meer verbondenheid en meer betekenis. Dit sluit aan bij de beweging 'Van Zorg naar Gewoon Leven'.

Het Team van de Toekomst richt zich op anders organiseren.

We nodigen u uit om uw organisatie en teams zo in te richten dat de ondersteuning nog beter past in de samenwerking met het netwerk van de klant. Daarbij staan mogelijkheden, wensen en talenten van klanten voorop. Kijken naar wat de klant zelf kan en wil is het uitgangspunt. Het is dus belangrijk om de ondersteuningsvraag van de klant goed in beeld te krijgen. Ook bekijkt u wat het netwerk kan doen. Het netwerk, zoals familie, vrienden of burens, wordt actief betrokken. Als dit nog niet zo is of er geen netwerk is, bekijkt u welke mogelijkheden er zijn om dit op te bouwen. Pas hierna komt de vraag in beeld welke ondersteuning en/of zorg nog meer nodig is.

Van zorgen 'voor' naar zorgen 'dat' (en zorgen 'met').

De medewerker van de toekomst is iemand die actief verbinding legt met het netwerk, vrijwilligers en de (lokale) samenleving. Zij richten zich dus niet alleen op het individu, maar ook op de omgeving. Waar mogelijk werken zij als community-verbinders. Zij stimuleren en coachen klanten om mee te doen in de maatschappij. Daarbij kijken zij wat nodig is vanuit het netwerk of de buurt. Scholing ondersteunt de omslag naar nieuw werken.

Technologie vergroot zelfstandigheid, veiligheid en sociaal contact.

Bij het team van de toekomst hoort ook het standaard inzetten van technologie waar dat helpt. Technologie heeft meerwaarde als deze de zelfstandigheid, participatie en eigen regie van klanten vergroot. Het helpt klanten om meer grip te krijgen op het dagelijks leven en meer contact te houden met hun omgeving. Denk aan een digitale dagplanner voor structuur. Met beeldzorg blijft het contact met begeleiders en het netwerk laagdrempelig. Technologie vervangt geen menselijk contact, maar ondersteunt dit. Technologie hoort vanzelfsprekend bij het werk en het team van de toekomst. Dit vraagt om goed gebruik, begeleiding en goede inbedding in het dagelijks handelen. Wij verwachten dat u hier actief op stuurt. Dit leest u ook in ons [innovatie- en optimalisatiebeleid](#).

Het Team van de Toekomst vraagt om een werkgever van de toekomst.

Medewerkers ontwikkelen nieuwe competenties zoals regie voeren, samenwerken en werken met digitale middelen. U biedt als werkgever uw medewerkers scholing en ruimte om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Dit gaat bijvoorbeeld om netwerkgericht werken, digitale vaardigheden en coachend ondersteunen. Ook verkent u de mogelijkheden voor het opleiden van zij-instromers.

3. Samenwerken aan een stevige regionale basis

Lees in dit hoofdstuk hoe wij dit inkoopdoel over samenwerking vormgeven.

3.1 Samenwerking in de regio.

Zorgaanbieders, het zorgkantoor en gemeenten werken samen aan een stevige basis voor zorg en essentiële voorzieningen in de regio. Juist door dit samen te doen, zetten we grotere stappen. Niet het individuele aanbod, maar regionale beschikbaarheid staat centraal. Regionale samenwerking is nodig om meer zorg thuis mogelijk te maken, om essentiële voorzieningen op orde te houden, om goede doorstroom te realiseren en om passend aanbod te organiseren voor mensen met een complexe zorgvraag. Samen optrekken helpt ook bij personeelstekorten en een groeiende zorgvraag. Zo blijft de zorg toegankelijk en betaalbaar en valt niemand tussen wal en schip.

In elke regio bestuurlijk commitment op samenwerking.

Elke regio zorgt voor een bestuurlijk overleg dat de regionale opgave draagt. Bestaat dit nog niet, dan wordt dit opgezet. Waar mogelijk sluiten we aan bij bestaande bestuurlijke overleggen. Zo bouwen we voort op wat er al is.

Wij verwachten dat in de basis elke zorgaanbieder deelneemt aan de regionale samenwerking. Dit vraagt dat de regionale samenwerking ook voldoende toegankelijk is voor elke zorgaanbieder die in de regio werkzaam is en bij wil dragen, groot of klein. Afspraken over de samenwerking legt u samen vast in de regio. Deze afspraken gaan over wat u samen organiseert, hoe u stuurt en besluiten neemt.

De regio bepaalt de inhoudelijke doelstellingen en prioriteiten.

Samen met partners in de regio bepaalt u hoe u invulling geeft aan de regionale opgave. In dit inkoopbeleid staan verschillende [thema's](#) die onderdeel zijn van deze regionale samenwerking. Deze thema's laat u terugkomen in de regionale overeenkomst. Per regio leggen de partners concrete afspraken vast voor meerdere jaren. Dit zijn afspraken tussen de regionale partners over de te behalen resultaten en wat de bijdrage van elke partner is.

We verwachten dat u de regionale ontwikkelopgave in uw strategie meeneemt.

Het is belangrijk dat u de regionale ontwikkelopgave vertaalt naar de bijdrage die u hieraan kan leveren. We ontwikkelen een hulpmiddel om u te helpen de thema's in goede samenhang te bezien. Deze gebruiken we zowel bij de gesprekken in de regio als in de individuele gesprekken die wij met uw organisatie voeren. Hiermee willen we borgen dat de verschillende onderdelen van ons regionale beleid worden gezien en toegepast als één samenhangend geheel van maatregelen.

Samenwerking beperkt zich niet tot de gehandicaptenzorg.

Samenwerking met partners uit andere domeinen is belangrijk voor het realiseren van de regionale opgave. Denk aan gemeenten en woningcorporaties, maar ook aan samenwerking met andere sectoren. Vooral de samenwerking met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is hierbij essentieel.

We vragen u om deze samenwerking actief op te zoeken. Dit kan bijvoorbeeld door gezamenlijk taskforce overleg te organiseren tussen de GZ en de GGZ of door samen regionale projecten uit te voeren. Als zorgkantoor zetten wij ons ook actief in om kansen te benutten en de samenwerking tussen de GZ en GGZ verder te versterken.

3.2 Thema's voor de regionale afspraken.

De verschillende thema's waar regionale samenwerking op nodig is, leest u hieronder. De volgorde en urgentie verschilt per regio. Prioriteiten stellen we samen, op basis van de regionale situatie.

- **Thuis, tenzij:** De regio investeert samen in de [beweging naar meer zorg thuis](#). Om dit mogelijk te maken, moeten de randvoorwaarden goed op orde zijn. Denk aan voldoende en passende woningen, inzet van behandeling, dagbesteding, logeerszorg en het gebruik van (zorg)technologie. Dit vraagt om nauwe samenwerking met gemeenten en woningcorporaties. De [regionale routekaart](#) helpt om samen te werken aan het realiseren van passende huisvesting voor klanten.
- **Zorgzame gemeenschappen:** De regio versterkt de beweging van zorg naar gewoon leven door te investeren in [zorgzame gemeenschappen](#). Dit zijn omgevingen waarin bewoners, professionals en organisaties elkaar kennen, ondersteunen en samen verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn in de wijk. Denk aan ontmoetingsplekken,

zichtbare professionals in de buurt, inzet van ervaringsdeskundigen en ondersteuning bij praktische of financiële vragen.

- **Regionaal doorstroomplan:** De regio maakt een regionaal [doorstroomplan](#) met afspraken over wat nodig is om klanten goed te laten doorstromen. Hierin staat ook welk aanbod door wie wordt geleverd. Het doel is om Wlz-klanten zorg te bieden op de juiste plek: zo thuis mogelijk.
- **Essentiële voorzieningen:** De regio maakt afspraken over het gezamenlijk beschikbaar houden van [essentiële voorzieningen](#). Denk aan voldoende behandelcapaciteit of een efficiënte gezamenlijke inzet van nachtzorg in de regio.
- **Efficiënte dagbesteding en regionaal vervoerscentrum:** De regio kijkt samen hoe het [dagbestedingsaanbod](#) efficiënt georganiseerd kan worden en werkt toe naar een regionaal vervoerscentrum.
- **Brede deskundigheidsbasis:** De regio zorgt voor structurele kennisdeling en samenwerking tussen zorgaanbieders. Zo wordt [expertise](#) beter benut en gedeeld, vooral voor complexe zorgvragen.
- **Gezamenlijke verantwoordelijkheid bij complexe zorgvragen:** De regio maakt afspraken over het plaatsen van klanten met een zeer [complexe zorgvraag](#). Zo zorgen we ervoor dat niemand tussen wal en schip valt.
- **Regiokaart complex:** De regio brengt vraag en aanbod voor complexe zorg in beeld met behulp van de [regiokaart complex](#). Op basis hiervan stelt de regio samen prioriteiten vast en pakt deze gezamenlijk op.

Regiobeelden sturen en monitoren.

We gebruiken regiobeelden en spiegelinformatie als basis voor sturing. Deze informatie laat zien waar de regio staat en wat er nodig is. Ook gebruiken we deze om zicht te houden op de voortgang en resultaten

3.3 Regionale middelen maken uitvoering mogelijk.

Wij reserveren financiële middelen om deze samenwerking en uitvoering waar nodig te ondersteunen². Hieruit kan bijvoorbeeld projectmanagement worden gefinancierd. Waar mogelijk combineren we dit voor GZ en GGZ. Dat versterkt samenwerking en efficiëntie.

Afspraken over de regionale middelen leggen we vast in een addendum bij de overeenkomst. Er kunnen afspraken gemaakt worden voor de periode 2027 tot en met 2029. Partijen leggen schriftelijk vast welke verplichtingen zij ten opzichte van elkaar aangaan en ondertekenen deze afspraken. Financiering door Zilveren Kruis vindt plaats via één of meerdere kassiers (één van de betrokken zorgaanbieders).

3.4 Doorstroom door de keten.

Wij verwachten dat personeel en vastgoed in de gehandicaptenzorg steeds schaarser worden. Daarom richten we ons niet alleen op meer plekken, maar juist op beter gebruik van bestaande plekken en medewerkers. We willen er samen met u voor zorgen dat hiermee méér ruimte ontstaat voor mensen met een complexere zorgvraag. Dit vraagt om samenwerking in de hele keten en een regionale blik.

De gewenste beweging loopt door de hele zorgketen.

Het doel is meer passende zorg en betere doorstroom. We willen dat zorgaanbieders klanten met een minder intensieve zorgvraag beter in beeld krijgen. Met regionale afspraken helpen we klanten naar meer zelfstandigheid of een minder intensieve zorgsetting. Hierdoor komt ruimte vrij voor klanten die intramurale zorg nodig hebben. Dit maakt doorstroom mogelijk vanuit intensieve zorg, zoals besloten opnameafdelingen. Zo ontstaat ruimte voor behandeling en instroom vanuit justitie of thuis. Dit helpt de hele keten vooruit.

Een gedeelde regionale visie is de eerste stap.

Samen met zorgpartijen spreken we een regionale visie af. Deze visie beschrijft de verwachte ontwikkelingen en de noodzaak van deze aanpak. Dit geeft richting en zorgt voor draagvlak.

² In het inkoopbeleid 2024-2026 zijn transitiemiddelen voor de gehandicaptenzorg opgenomen. Momenteel worden er tussen de sector en VWS gesprekken gevoerd over het sluiten van een akkoord. Het beschikbaar stellen van transitiemiddelen voor de GZ kan hier mogelijk een onderdeel van zijn. Op het moment van publicatie van het inkoopbeleid voor 2027 en verder is hierover nog geen besluit genomen. Zodra hierover meer duidelijkheid ontstaat, informeren wij u hierover. Waar passend zijn eventuele landelijke transitiemiddelen voortliggend op de financiële middelen die Zilveren Kruis hier vanuit de contracteerruimte voor beschikbaar stelt.

U brengt doorstroomkansen systematisch in beeld.

U screent al uw klanten op mogelijkheden voor lichtere zorg. Kan iemand zo'n stap niet direct zetten, maar wel binnen 1 tot 3 jaar? Dan maakt u samen een ontwikkelplan. Deze screenings geven per regio inzicht in aantallen, zorgprofielen en benodigde woonoplossingen per gemeente. Op basis hiervan wordt de regionale potentie voor doorstroom bepaald en kan een regionaal doorstroomplan worden opgesteld.

We voeren het plan uit via een duidelijke projectstructuur.

Deze structuur helpt de regio om de doorstroom goed te realiseren. Samen brengen we in beeld wat nodig is en welke knelpunten er zijn. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over een goede en warme overdracht tussen zorgaanbieders. In de regio spreken partners ook af wanneer en hoe kennis en expertise worden gedeeld.

Samenwerking met gemeenten en woningbouwcorporaties over beschikbare woningen hoort hierbij. Via de [regionale routekaart](#) kunnen partijen in de regio samenwerken aan de huisvestingsopgave. Waar nodig zijn regionaal financiële middelen beschikbaar om de uitvoering van de plannen te ondersteunen.

3.5 Samen borgen we essentiële voorzieningen in de regio.

Het is belangrijk dat essentiële voorzieningen duurzaam beschikbaar blijven in elke regio. Zo houdt iedere klant toegang tot deze voorzieningen. De beschikbaarheid van deze voorzieningen bespreken we binnen de regionale opgave en krijgt een plek in de regionale overeenkomst. Ook de invulling van de medisch-generalistische zorg (MGZ), volgens het landelijke convenant, hoort hierbij. Samen geven deze afspraken richting aan de regionale inzet. Via het ontwikkelen van regiobeelden brengen we witte vlekken in kaart.

Diverse essentiële voorzieningen krijgen 100% van het NZa tarief.

Wij vergoeden 100% van het tarief van de NZa voor zorg die wij aanmerken als essentieel. Deze voorzieningen zijn onmisbaar binnen de zorgketen en het regionale aanbod. Zonder deze zorg loopt de toegang in de regio vast. Denk bijvoorbeeld aan crisiszorg. De toegankelijkheid staat vaak onder druk, omdat 1 of enkele aanbieders deze zorg leveren. Daarom stimuleren wij deze voorzieningen met een tariefsopslag. Zo dragen we samen bij aan de toegankelijkheid van deze zorg in de regio. Het gaat om de volgende prestaties:

Prestatieomschrijving	Prestatiecode
Logeren GZ	Z999, Z1000, Z1001, Z1002, Z1006
Observatie	Z912
Crisiszorg GZ	Z492, Z493, Z494, Z560
COT	COT01, COT02, COT03, COT04, COT05, COT06
Beveiligde zorg	Z1007, Z1008, Z280, Z922
Behandeling SGLVG/gespecialiseerde behandelenzorg	H338, Z981, V981
Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg	H540

Extra aandacht voor logeerszorg.

Ook logeerszorg is een essentiële voorziening. Voor logeerszorg krijgen we al langere tijd signalen dat dit aanbod onvoldoende beschikbaar is in de regio's. Daarom zetten we meerdere beleidsinstrumenten hiervoor in. Naast het 100% tarief voor de logeersprestaties zetten we via het instrument 'Gericht Contracteren' in op de uitbreiding van het logeeraanbod. In de bijlage '[Gericht Contracteren](#)' (pdf) leest u wat hiervoor de voorwaarden zijn. Ook zetten we stevig in op een aanpassing van de landelijke prestatiestructuur voor logeren in de GZ.

3.6 Aandacht voor het vergroten van deskundigheid.

Investeren in deskundigheid helpt teams om klanten met een afwijkende zorgvraag te blijven begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan mensen met bijkomende verslaving, psychiatrie of ouderdomsklachten. Door teams beter toe te rusten is uitplaatsing naar specialistische zorg minder nodig. Ook helpt dit bij nieuwe instroom, zodat afwijzen op basis van contra-indicaties minder snel nodig is. Daarom stimuleren wij structurele kennisdeling in de regio.

Deskundigheid als onderdeel van de regionale opgave.

In elke regio is er aandacht voor het vergroten van deskundigheid. Dit kan door kennisdeling structureel te organiseren binnen regionale samenwerkingen. Ook gaat het om het inzetten en delen van expertise, bijvoorbeeld via consultatie, coaching of het tijdelijk inzetten van specialistische kennis van andere organisaties. Daarnaast maken regio's scholingsplannen om teams beter toe te rusten voor complexere zorg. Zo groeit kennis op meerdere plekken in de regio. Dit vraagt om duidelijke bestuurlijke keuzes én om de bereidheid kennis te delen buiten de eigen organisatie.

Heeft u specialistische kennis? Dan vragen we u om deze te delen. Dat zien wij als een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door expertise te delen, versterken we samen de kwaliteit van zorg en capaciteit.

3.7 Efficiënt organiseren van dagbesteding en vervoer.

Door het efficiënt organiseren van dagbesteding en samenwerking in de regio, ook op vervoer, werken we toe naar een efficiënte inzet van schaarse middelen.

Dagbesteding organiseren we slimmer en meer samen.

Naast een betekenisvolle [daginvulling](#) bekijken we hoe dagbesteding slimmer kan. Dit doen we onder andere door digitale dagbesteding te vergroten. Ook vragen we om regionale afstemming en samenwerking. Zo ontstaat een goede balans tussen wat klanten nodig hebben, voldoende schaalgrootte/bezetting en efficiënt vervoer. Dit vraagt om een verschuiving van individuele verantwoordelijkheid naar een gezamenlijke regionale blik. Regio's krijgen zo zicht op bezetting en vervoer. In elke regio is inzicht in de bezettingsgraad van dagbestedingslocaties. Ook is er een gezamenlijk plan om de bezetting van de dagbestedingslocaties te verbeteren en de efficiëntie in het vervoer te vergroten. Zo benutten we locaties en vervoer beter.

Elke regio werkt toe naar een regionaal vervoerscoördinatiepunt.

In elke regio is er binnen 1 jaar een inventarisatie en plan uitgewerkt. Dit plan is uiterlijk in 2027 gereed, uitvoering van dat plan vindt in de jaren daarna plaats. Hiermee verminderen we vervoersbewegingen.

Wij koppelen extramurale dagbesteding aan zorgzwaarte in plaats van groepsgrootte.

Voor de H800 prestaties voor dagbesteding hanteren wij dezelfde indeling in profielen als door de NZa wordt gebruikt bij de H900 prestaties voor dagbesteding. Hierdoor is er een koppeling in de relatie tussen zorgzwaarte en zorgkosten. De richtlijn voor de declaratie van de prestatie dagbesteding H800 verandert hierdoor. De declaratie van het onderdeel dagbesteding binnen het MPT moet passen bij de zzp indicatie zoals in de tabel hieronder. De richtlijn voor deze tabel is de verdeling die is opgenomen in de NZa beleidsregel voor intramurale dagbesteding (H900). Deze indeling geldt zowel voor volwassenen als voor jongeren tot 18 jaar.

Licht	Midden	Zwaar
VG1 – VG4	VG5 en VG6	VG7 en VG8
LG7	LG2, LG4, LG6	LG1, LG3, LG5
ZG aud1, ZG aud4	ZG aud2	ZG aud3
ZG vis2, ZG vis3	ZG vis1	ZG vis4, ZG vis5

Voor zorgaanbieders waarvoor deze wijziging een grote financiële impact heeft, spreken we een overgangsregeling af. Wij nemen contact op met deze zorgaanbieders.

4. Voldoende expertise en aanbod voor complexe zorg

Lees in dit hoofdstuk hoe wij dit inkoopdoel voor klanten met een complexe zorgvraag vormgeven.

4.1 Regionale samenwerkingsafspraken zodat niemand tussen wal en schip valt.

We zien dat het steeds lastiger wordt om plekken te vinden voor klanten met een zeer complexe zorgvraag. De complexiteit neemt toe en de druk op zorgaanbieders en zorgteams is groot. Toch willen we ook voor deze klanten de zorg toegankelijk houden. Zilveren Kruis blijft de casuïstiekbesprekingen coördineren, maar vraagt ook actieve deelname van zorgaanbieders. Plaatsing van complexe casussen vindt plaats in de regio, waar zorgaanbieders gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor is het nodig dat bestuurders zich committeren aan een gezamenlijke werkwijze. Dat doen we begin 2027 op bestuurlijk niveau binnen het regionaal samenwerkingsverband. Daarmee hebben we een goede basis voor onderling vertrouwen en voor de manier waarop we in de regio samenwerken. Dit vergroot de kans om oplossingen te realiseren met behulp van de tafel complexe casuïstiek (taskforces).

Een escalatieladder is een belangrijk onderdeel van de regionale samenwerkingsafspraken.

In de praktijk lukt het deelnemers niet altijd om via de taskforces een geschikte plek te vinden. Voor deze situaties maken we afspraken over wie dan bepaalt welke zorgaanbieder toch een plek biedt en hoe dit besluit tot stand komt. Dat doen we door het afspreken van een escalatieladder, waarvan de inhoud per regio kan verschillen.

Hulpmiddelen ondersteunen het vinden van een passende plek.

Bij complexe situaties gebruiken we landelijk ontwikkelde hulpmiddelen. Het ministerie van VWS beschrijft [de rollen bij casuïstiek in 6 stappen](#). Wij verwachten dat alle zorgaanbieders deze stappen volgen. Voor het goed functioneren van een regionale taskforce is het belangrijk dat deelnemers voldoende mandaat hebben om een besluit te nemen of de zorgaanbieder de betreffende klant zorg kan verlenen. Er is een landelijk formulier ontwikkeld voor aanmelding van een casus voor bespreking in de taskforce. Het gaat om het [formulier 'Passende plek'](#). Dit formulier wordt in alle regio's gebruikt, zodat per casus alle relevante informatie beschikbaar is. Dat maakt bespreking in de taskforces efficiënter.

Per casus wordt vastgelegd wat een zorgaanbieder nodig heeft van anderen.

Voor het bieden van een passende woonzorgplek heeft een zorgaanbieder soms hulp nodig van anderen. Dit is bijvoorbeeld nodig om specifieke deskundigheid in te zetten die de zorgaanbieder niet zelf in huis heeft. Voor het vastleggen van de afspraken per casus (wie doet wat) ontwikkelen we een format (samenwerkingsafspraken complexe casuïstiek). Dit format is gebaseerd op het format dat wordt gebruikt in de Levensloopaanpak. Doel is om duidelijk te maken wat een zorgaanbieder nodig heeft van anderen en welke toezeggingen worden gedaan.

Een regionaal aanbidersoverzicht helpt bij snellere passende plaatsing.

Zorgaanbieders kennen het beschikbare zorgaanbod in een regio nog onvoldoende. De ervaring leert dat het delen van informatie over elkaars aanbod helpt. Daarom vragen we zorgaanbieders om een regionaal overzicht van het zorgaanbod te maken en dit met elkaar te delen. Dit is bedoeld als hulpmiddel en om te kijken wie wat kan bijdragen in de regio en waar er voor een klant passende zorg of ondersteuning kan worden geboden. Een mooi voorbeeld hiervan wordt gebruikt door [MatchFriesland](#) en werkt in de praktijk heel goed.

4.2 De regiokaart complex als hulpmiddel bij de regionale opgave.

De regiokaart complex maakt knelpunten tussen vraag en aanbod zichtbaar. Dit zorgt voor het doelgericht oplossen van knelpunten. In de GZ gaan alle regio's werken met de regiokaart complex. We werken toe naar een eerste vulling van de regiokaart complex in elke regio, zodat de knelpunten inzichtelijk worden en er geprioriteerd kan worden. Uiterlijk eind 2027 is de regiokaart complex voor elke regio gevuld. En eind 2028 is voor de eerste prioriteiten per regio een plan van aanpak gereed.

4.3 Ondersteuning bij het realiseren van nieuwe woonplekken met een specifieke context.

Het realiseren van nieuwe woonplekken vraagt vaak om extra investeringen. Daarom ondersteunen wij zorgaanbieders met Gericht Contracteren. Met een eenmalige financiële bijdrage stimuleren we de ontwikkeling van nieuw en passend woonaanbod voor specifieke doelgroepen.

In de bijlage '[Gericht Contracteren](#)' ([pdf](#)) leest u meer over de doelgroepen, soorten woonplekken en investeringen die in aanmerking komen voor deze vergoeding.

4.4 Urgentie bepaalt plaatsing bij een VG7+ locatie.

VG7+ is bedoeld voor mensen met een zeer complexe zorgvraag. Komt er op een VG7+ locatie een plek vrij, dan bepaalt de urgentie van de zorgvraag wie als eerste geplaatst wordt. Hoe lang iemand al op de wachtlijst staat bij een zorgaanbieder weegt daarbij minder zwaar. In de regio bepalen we samen met de zorgaanbieder die VG7+ zorg levert de volgorde van plaatsing. Daarom vragen we u om bij het (verwacht) vrijkomen van een VG7+ plek altijd en op tijd contact op te nemen met het zorgkantoor. De benodigde contactgegevens delen wij met u. Meer informatie over VG7+ en de overige afspraken leest u in het [landelijke beleidskader](#) ([pdf](#)).

4.5 Methodisch werken als basis voor passende en efficiënte zorg.

Methodisch werken is de basis voor het goed organiseren van (zeer) complexe zorg. We verwachten dat zorgaanbieders die complexe zorg leveren, werken met een goed ingevoerde methodiek. Deze beschrijft u in uw visie of in het kwaliteitsbeeld. We bespreken dit tijdens de kwaliteitsdialoog of de meerzorgdialoog. Voor ons is vooral belangrijk hoe u de methodiek in de praktijk toepast. Daarom gaan we in gesprek over hoe de methodiek is ingebed in teams en op locaties.

Er zijn verschillende goede voorbeelden van methodieken: zoals Triple-C van ASVZ en Bouwstenen intensieve zorg van 's Heeren Loo. Er bestaan ook andere erkende methodieken. Methodieken die landelijk bekend zijn, zijn beschreven door Alliade in de grote methodiekengids. Deze is te vinden en te downloaden via het [Kennisplein Gehandicaptenzorg](#).

Bij klanten met een zeer hoge begeleidingsintensiteit, zoals één-op-één begeleiding of intensiever, gaat het expertisebureau meerzorg met zorgaanbieders in gesprek. Samen met het CCE voeren we gesprekken op locatie. Het doel is om te beoordelen of deze hoge begeleidingsintensiteit nog passend is en, waar mogelijk, kan worden aangepast. Wij vinden dit belangrijk voor de kwaliteit van leven van de klant, het werken met schaarse zorgmedewerkers en een doelmatige inzet van zorg. We vragen u ook zelf om regelmatig opnieuw te kijken naar mogelijkheden om de zorg voor deze klanten passend te organiseren.

5. Tarieven en volumes

In dit hoofdstuk leest u meer over de bekostigingssystematiek en wat dit betekent voor de tariefpercentages die we gebruiken. Ook leest u welke afspraken we met u maken over volumes.

5.1 De beschikbare contracteerruimte zetten we in voor zorg.

We gebruiken het belangrijkste deel van de contracteerruimte voor de vergoeding van de tariefpercentages voor zorg en voor de NHC/NIC. Zilveren Kruis reserveert daarnaast een klein deel van de GZ-contracteerruimte (0,2%) voor onvoorziene omstandigheden.

5.2 Een landelijk tariefmodel met vertrektariefpercentage als uitgangspunt.

Vanaf 2021 werken zorgkantoren met een landelijk tariefmodel. In dit eerste model werd er voor alle zorgaanbieders over alle sectoren één reëel tariefpercentage bepaald.

Vanaf 2024 berekent het tariefmodel per sector een richttariefpercentage, waarbij zowel aantallen als marktaandeel van zorgaanbieders wordt meegenomen. Met dit tarief ontvangt minimaal 75% van zowel het aantal als van het marktaandeel van zorgaanbieders een kostendekkende vergoeding. Door een norm van 75% te hanteren geldt er voor de overige aanbieders een doelmatigheidsprikkels³.

Om meer recht te doen aan verschillen tussen zorgaanbieders zoals gevraagd door de branches en de wens voor meer tariefdifferentiatie, werken de zorgkantoren per 2027 met een verfijnd model, waarbij de zorgkantoren gebruik hebben gemaakt van de ondersteuning van een onafhankelijk adviesbureau.

Op basis van de analyse van de declaratiegegevens 2024 en jaarrekeningdata 2024 zijn aanbieders in groepen (ook wel clusters genoemd) ingedeeld. Aanbieders in een groep leveren dezelfde zorg en hebben een vergelijkbare bedrijfsvoering op basis van objectieve kenmerken. Niet alleen is daarbij relevant welke (soort) zorgprestaties een zorgaanbieder levert, maar ook of de 'kostenkant' van de zorgaanbieder vergelijkbaar is met de andere zorgaanbieders in hetzelfde cluster. In de mate van clustering is de feedback van overleggen met de branches meegenomen. Dit heeft geleid tot in totaal zeven clusters.

Verfijnd tariefmodel.

Per 2027 hanteren zorgkantoren een beleidsmatig verfijnd tariefmodel. De verfijning betreft het corrigeren van het model voor de NHC/NIC component en een clustering van vergelijkbare aanbieders. Met dit laatste punt willen zorgkantoren meer recht doen aan de verschillen die bestaan tussen typen aanbieders in verschillende sectoren.

1. Corrigeren voor NHC/NIC component.

Als gevolg van de uitspraak van het Hof⁴ hebben zorgkantoren (met terugwerkende kracht) het saldo van de financiële baten en lasten toegevoegd aan het rekenmodel⁵. Hierdoor ontstond een overlap, een deel van die lasten werd namelijk óók vergoed via het 100% tarief voor NHC/NIC. Zorgkantoren hebben ervoor gekozen om – met de ingang van het nieuwe beleid – deze overlap eruit te halen door het model te corrigeren voor de NHC/NIC component, om hiermee ook recht te doen aan de doelmatigheidsopdracht die zorgkantoren hebben.

2. Clustering van vergelijkbare aanbieders binnen sectoren.

Binnen een sector worden vergelijkbare aanbieders geclusterd. Een zorgaanbieder wordt toegedeeld naar de sector waar de landelijke omzet het grootste is. Voor de GZ zijn er de volgende clusters:

- Cluster A: volledig extramuraal
- Cluster B: Gedeeltelijk intramuraal

³ ECLI:NL:GHDHA:2024:199, Gerechtshof Den Haag

⁴ ECLI:NL:GHDHA:2024:199, Gerechtshof Den Haag

⁵ Zie Nota van Wijziging d.d. 31 mei 2024

Vervolgens berekenen we per cluster het vertrektariefpercentage. Op deze manier kunnen zorgkantoren reële tarieven afspreken, die beter passen bij het type zorgaanbieder. Het verfijnde model is verder toegelicht in het document '[Onderbouwing vertrektarieven Wlz 2027](#)' (pdf).

Voor de berekening van de vertrektariefpercentages zijn de laatst beschikbare jaarverslagen van de zorgaanbieders nodig. Voor de vertrektariefpercentages 2027 betreffen dit de beschikbare jaarverslagen 2025. Deze jaarverslagen worden pas op 1 juni gepubliceerd. Dit betekent dat de vertrektariefpercentages 2027 pas na deze datum berekend kunnen worden en daarom uiterlijk op 4 september 2026 gepubliceerd worden. Dan zal ook een nieuwe versie van bijlage 7 gepubliceerd worden.

In het proces van de Nota van Inlichtingen kunnen zorgaanbieders vragen stellen over de wijze waarop de vertrektariefpercentages 2027 berekend worden. Na publicatie van de vertrektariefpercentages 2027 kunnen zorgaanbieders bezwaren uiten tegen de hoogte van de vertrektariefpercentages 2027 en de (wijze van) totstandkoming daarvan. Hiervoor geldt een vervaltermijn van 20 kalenderdagen.

Het staat zorgaanbieders vrij om binnen deze termijn mee te delen dat zij hun inschrijving niet langer gestand doen naar aanleiding van het op 4 september 2026 gepubliceerde vertrektariefpercentages 2027. U kunt dit kenbaar maken per email via dit adres: zorginkoopwllz@zilverenkruis.nl.

Het vertrektariefpercentage is voor de zorgkantoren een gezamenlijk uitgangspunt voor de inkoop. Het is geen minimum- of maximumtarief. Zorgkantoren kunnen zowel een hoger als een lager tariefpercentage afspreken.

Zorgaanbieders waarvoor het geldende vertrektariefpercentage aangevuld met eventuele regionale aanvullende afspraken op basis van dit beleid aantoonbaar niet kostendekkend is, kunnen een beroep doen op de [hardheidsclausule](#).

Landelijk cluster/ Zorgaanbieders met klanten in meerdere sectoren.

Er is afgesproken dat aanbieders landelijk op basis van omzet worden geclusterd en ook landelijk in hetzelfde cluster worden gecontracteerd. U wordt op 1 juni over uw cluster geïnformeerd door het zorgkantoor. Als dit cluster afwijkt van de verwachting, neemt u dan voor 1 juli 2026 contact op met uw zorginkoper. Voor enkele aanbieders leidt dit tot een verschuiving van de sector waaronder de aanbieder gecontracteerd wordt. De prestaties bij sectorvreemde indicaties worden vergoed voor het door de aanbieder afgesproken (eigen sector) percentage.

Voor in 2026 nieuw gecontracteerde aanbieders zonder realisatie bepaalt het zorgkantoor op basis van de inkoopafspraken met de betreffende aanbieder het cluster voor 2027.

5.3 Tariefsystematiek voor zorgaanbieders die al een overeenkomst hebben.

Voor de af te spreken tariefpercentages maken we onderscheid tussen zorgaanbieders die al een overeenkomst hebben met Zilveren Kruis en/of een ander zorgkantoor (bestaande zorgaanbieders) en zorgaanbieders die nieuw zijn voor de zorgkantoren⁶. In deze paragraaf leest u meer over de tariefpercentages die we afspreken met bestaande zorgaanbieders.

We spreken het landelijke vertrektariefpercentage af voor zorg.

Met alle bestaande zorgaanbieders spreken we het landelijke vertrektariefpercentage af voor zorg. Daarbij geldt het tariefpercentage van het cluster waarin de zorgaanbieder valt. Een klein aantal zorgaanbieders heeft meerdere overeenkomsten. In dat geval geldt per overeenkomst het vertrektariefpercentage van de bijbehorende sector.

100% van het NZa tarief voor diverse essentiële voorzieningen.

Wij vergoeden 100% van het tarief van de NZa voor zorg die wij aanmerken als [essentieel](#). Deze voorzieningen zijn onmisbaar binnen de zorgketen en het regionale aanbod. In [bijlage 8 \(xlsx\)](#) leest u over welke prestaties het gaat.

De vergoeding voor NHC/NIC is 100%.

Investeringen in vastgoed vragen om zekerheid voor zorgaanbieders. Daarom vergoeden we voor NHC/NIC 100% van het NZa-tarief. We verwachten dat u de NHC-inkomsten gebruikt voor de exploitatie, het onderhoud en de verduurzaming van uw vastgoed. Zo blijven gebouwen veilig, toekomstbestendig en passend bij de zorg.

⁶ In de paragraaf [We maken onderscheid tussen bestaande en nieuwe zorgaanbieders](#) leest u meer over het onderscheid tussen bestaande en nieuwe zorgaanbieders.

Type zorgaanbieder	Tariefpercentage voor zorg 2027-2029	Tariefpercentage essentiële voorzieningen 2027-2029	Tariefpercentage NHC/NIC 2027-2029
Volledig extramuraal	Vertrektariefpercentage cluster volledig extramuraal (volgt 04-09-2026)	100%	100%
Gedeeltelijk intramuraal	Vertrektariefpercentage cluster gedeeltelijk intramuraal (volgt 04-09-2026)	100%	100%

5.4 Met een deel van de zorgaanbieders spreken we een lager tariefpercentage af.

We vinden het belangrijk om beschikbare middelen doelmatig te gebruiken. Daarom spreken we met een deel van de zorgaanbieders een lager tariefpercentage af. Dit tarief ligt 2% onder het vertrektariefpercentage.

Dit lagere tarief geldt voor zorgaanbieders die:

- Minder bijdragen aan regionale ontwikkeling;
- Niet de volledige breedte van zorg binnen een prestatie leveren, of een zorgzwaartemix hebben die lager is dan gemiddeld;
- Een hoog positief resultaat hebben.

De zorgaanbieders voor wie dit geldt, ontvangen hierover uiterlijk 28-08-2026 bericht.

We hebben daarnaast de mogelijkheid om in gesprek te gaan en maatwerkafspraken te maken over het tariefpercentage. Dit doen we vanuit oogpunt van doelmatigheid.

Een vrijwillig lager tariefpercentage.

U kunt vrijwillig kiezen voor een lager tariefpercentage. Bijvoorbeeld omdat u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid wilt nemen en de zorgkosten wilt beperken. U kunt bij ons aangeven dat u een lager tariefpercentage wilt. Samen maakt u hierover afspraken. De definitieve afspraken leggen we vast in de overeenkomst.

5.5 In uitzonderlijke situaties geldt de hardheidsclausule.

Heeft de gehanteerde tariefsystematiek een voor uw organisatie onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg, dan is er in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid voor individuele aanbieders om een beroep te doen op de hardheidsclausule. Onder onvoorzien verstaan wij dat in een specifieke situatie voor een individuele aanbieder door toepassing van de tariefsystematiek (landelijk vertrektariefpercentage en regionale aanpassingsmogelijkheden) een onredelijk benadelend effect optreedt. De term onvoorzien wordt hier dus uitgelegd als onverwacht effect van de tariefsystematiek. Hierbij is het van belang dat u kunt aantonen dat u op dit moment op een doelmatige manier de zorg levert en het voor u geldende tariefpercentage voor uw organisatie niet kostendekkend is. We nemen uw financiële positie en organisatiestructuur mee en beoordelen of er nog operationele verbeteringen mogelijk zijn. Bij de financiële positie zal onder meer gekeken worden naar het eigen vermogen van de organisatie. Wij betrekken daarbij ook de financiële reserves van de zorgaanbieder. Bij de afweging om de hardheidsclausule toe te passen nemen we ook de zorgplicht en het perspectief voor de langere termijn mee. Dit alles nemen we mee bij de beoordeling of en welke afspraken we maken op basis van de hardheidsclausule. In de paragraaf [U kunt een beroep doen op de hardheidsclausule](#) leest u meer over hoe u een beroep kunt doen op de hardheidsclausule.

5.6 Met nieuwe zorgaanbieders spreken we een lager tariefpercentage af.

We waarderen het dat nieuwe zorgaanbieders een leemte in de regio opvullen of vernieuwing brengen. Tegelijk zien we dat nieuwe zorgaanbieders vaak minder bijdragen aan regionale ontwikkeling. Ook leveren ze vaak niet de volledige breedte van zorg binnen een prestatie of is de zorgzwaartemix lager dan gemiddeld. Daarom geldt voor nieuwe zorgaanbieders een lager tariefpercentage.

Type zorgaanbieder	Tariefpercentage voor zorg 2027-2029	Tariefpercentage essentiële voorzieningen 2027-2029	Tariefpercentage NHC/NIC 2027-2029
Volledig extramuraal	Vertrektariefpercentage cluster volledig extramuraal – 2% (volgt 04-09-2026)	100%	100%
Gedeeltelijk intramuraal	Vertrektariefpercentage cluster gedeeltelijk intramuraal - 2% (volgt 04-09-2026)	100%	100%

In bijzondere situaties kunnen we een hoger tariefpercentage afspreken, tot maximaal het vertrektarief van het cluster waarin u valt. Dit kan bijvoorbeeld als u zorg levert aan complexe doelgroepen, zoals hoog complexe of essentiële zorg, en een lager tarief niet voldoende is. Dit geldt ook als u in 2026 zorg heeft geleverd via een persoonsgebonden budget (pgb) en het nieuwe tarief lager uitkomt dan uw huidige pgb-vergoeding. Wilt u in aanmerking komen voor een hoger tariefpercentage? Bespreek dit dan tijdens het gesprek met ons over uw inschrijving.

5.7 Voor sectorvreemde zorg vergoeden we het afgesproken tariefpercentage.

De vergoeding van sectorvreemde zorg wijzigt. Vanaf 2027 vergoeden we voor sectorvreemde zorg het tariefpercentage dat met de zorgaanbieder is afgesproken op basis van het cluster waar de zorgaanbieder in valt. We spreken van sectorvreemde zorg als een zorgaanbieder een prestatie levert uit een andere sector dan de hoofdsector van de zorgaanbieder, bijvoorbeeld een ZZP. U stemt met uw zorginkoper af of u deze zorg kunt leveren en declareren. Dit doen we in een inhoudelijk gesprek. Daarbij beoordelen we of u deze zorg op een verantwoorde manier kunt leveren.

5.8 Door persoonsvolgende bekostiging betalen we de geleverde zorg.

Met ons meerjarige inkoopbeleid willen we binnen de beschikbare middelen goede zorg blijven bieden aan huidige en toekomstige klanten. Daarom geven we klanten de ruimte om zorg te kiezen die bij hen past. Tegelijk bieden we u ruimte om deze passende zorg te leveren.

De keuze van de klant bepaalt het betaalde volume.

Door persoonsvolgende bekostiging groeit het zorgvolume mee met de zorgvraag van klanten. U zit daarbij niet vast aan volumeafspraken. Dit geldt niet voor crisiszorg en behandeling. We doen dit zolang het past binnen de beschikbare contracteerruimte. Om voldoende zekerheid te bieden, hebben we mogelijkheid voor een [tussentijdse herschikking](#).

Het uitgangspunt van persoonsvolgendheid passen we toe in ons betaalbeleid.

Zo sluiten onze afspraken en betalingen goed aan op de praktijk. Klanten kiezen niet allemaal per 1 januari opnieuw voor zorg. Daar houden we rekening mee in ons betaalbeleid. Met dit betaalbeleid zorgen we ervoor dat de zorg ook bij de overgang naar een nieuw jaar gewoon doorgaat. U vindt het betaalbeleid in [bijlage 9 \(pdf\)](#).

6. Aanvullende thema's op het inkoopbeleid

U leest in dit hoofdstuk meer informatie over enkele belangrijke inhoudelijke thema's.

6.1 Samen voor een toegankelijke en betaalbare Meerzorgregeling.

Het doel van de Meerzorgregeling is om te komen tot passende financiering voor tijdelijke extra zorg die mensen met een Wlz-indicatie nodig hebben. Het gaat om zorg die de zorgvraag op basis van het geïndiceerde zorgprofiel ruim overstijgt. We sturen binnen de wettelijke en beleidskaders op de toegankelijkheid én betaalbaarheid van de Meerzorgregeling.

We stoppen met het meerzorgplafond.

We zagen in 2024 en 2025 een duidelijke afname van de sterke groei van eerdere jaren. Het intensieve overleg met zorgaanbieders over het meerzorgplafond droeg hieraan bij, maar was ook een extra administratieve last. Daarom stoppen we per 1 januari 2027 met het meerzorgplafond. Als de kosten van meerzorg toch weer harder stijgen dan verwacht, behouden we ons het recht voor om aanvullende maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door opnieuw te gaan werken met een meerzorgplafond. We leggen zulke maatregelen vast in een aanvulling op het inkoopbeleid van dat jaar.

We gaan door met de meerzorgdialoog.

Bij meer dan 10 klanten met meerzorg voeren we een meerzorgdialoog. Als er aanleiding toe is, kunnen we ook een meerzorgdialoog voeren bij minder klanten. De kwaliteit van de zorg voor de hele groep klanten die meerzorg ontvangt staat hierbij centraal. Een dialoog is niet vrijblijvend. We willen graag weten waar u tegenaan loopt en zijn uw partner bij het vinden van oplossingen die passen bij uw organisatie. En natuurlijk horen we ook graag uw goede voorbeelden, zodat we daar anderen weer mee kunnen inspireren. Handvat voor het gesprek is het vooraf ingediende Meerzorgplan. Daarin beschrijft u een terugblik op het voorgaande jaar en een vooruitblik op het lopende jaar.

Expertise van anderen benutten bij een meerzorgaanvraag.

Bij een aanvraag voor meerzorg maakt u gebruik van de expertise van anderen. Minimaal één keer in de 3 jaar vraagt u advies aan een collega-zorgaanbieder of bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Zij beschikken over specialistische kennis die kan helpen bij het verbeteren van de zorg voor de klant of klantgroep waarvoor meerzorg wordt aangevraagd. Soms ontstaat een meerzorgvraag doordat de basiszorg of de omgeving niet goed aansluit. Een collega-zorgaanbieder of het CCE kan dan adviseren over mogelijke verbeteringen. Dit gaat bijvoorbeeld over huisvesting, samenstelling van de groep, contact met naasten, deskundigheid van medewerkers, teamstabiliteit, een veilige woonomgeving of het inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen. Wij gebruiken dit advies bij de beoordeling van de meerzorgaanvraag. Ook bij het zorgvuldig afbouwen van meerzorg kan dit advies helpen.

Verplichte consultatie bij LVHC-doelgroepen.

Voor klanten met een Laag Volume, Hoog Complex (LVHC) zorgvraag is consultatie of advies verplicht voordat een meerzorgaanvraag kan worden ingediend. Dit geldt voor de volgende doelgroepen: Huntington, Korsakov, Langdurige Bewustzijnsstoornissen (LBS), Dementie met Zeer Ernstig Probleemgedrag (DZEP), zeer ernstige gerontopsychiatrische aandoeningen (GP+), Niet Aangeboren Hersenletsel+ (NAH+) en Multiple Sclerose+ (MS+). De consultatie vindt plaats bij een Doelgroep Expertise Centrum (DEC) of een Regionaal Expertisecentrum (REC). Het doel is om te beoordelen welke zorg het best passend is. Het advies kan leiden tot het beperken van meerzorg of tot een advies voor (tijdelijke) opname in een DEC of REC.

Goede verantwoording van meerzorg.

Een goede verantwoording van de geleverde meerzorg is belangrijk. We gebruiken hiervoor evaluaties en materiële controles. We verwachten dat u kunt laten zien hoe de ontvangen meerzorgmiddelen zijn ingezet, zowel inhoudelijk als financieel. Ook in de komende beleidsperiode besteden we hier aandacht aan. Als uit een materiële controle blijkt dat (een deel van) de meerzorgmiddelen niet juist is besteed, kan dit betekenen dat u dit bedrag moet terugbetalen.

6.2 Crisiszorg.

Onder crisiszorg verstaan we crisisopvang en/of spoedzorg. Crisiszorg contracteren wij op basis van de (regionale) crisisregelingen. Voor crisiszorg geldt een landelijk protocol. U leest dit op zilverenkruis.nl/zorgkantoor.

We kopen crisiszorg selectief in.

We doen dit op prestatieniveau. We verwachten voldoende crisisplekken bij bestaande aanbieders in te kunnen kopen. Daarom maken we alleen afspraken met bestaande crisis-aanbieders. Heeft u in 2026 géén afspraken over crisiszorg? Dan maken we in beginsel geen afspraak.

U ontvangt een vergoeding voor onbenutte crisisdagen.

Deze vergoeding staat voor gegarandeerde beschikbaarheid van zorg. We spreken af dat u de plekken het hele jaar beschikbaar houdt. Dit geeft zekerheid voor klanten in crisissituaties. We verwachten dat u rekening houdt met de verschillende doelgroepen bij de opvang in crisissituaties, waaronder de opvang van mensen met een Inbewaringstelling (IBS).

We werken met Crisis Ondersteuningsteams.

Voor de GZ zijn er 3 NZa-prestaties voor crisiszorg. We maken afspraken voor de categorieën licht, midden en zwaar. Voor de verdeling sluiten we aan bij de historische afspraken over crisisfinanciering. In elke zorgkantoorregio is er een crisisregisseur werkzaam en is er een werkend COT. De crisisregisseur beoordeelt of er sprake is van een crisis en wijst in het geval van crisis de klant toe aan een COT of aan een crisiszorgaanbieder met een beschikbaar crisisbed. Het COT ondersteunt teams op locatie om crisisopnames te voorkomen of te verkorten.

Bij een lagere bezettingsgraad passen we de afspraak bij de herschikking aan.

Het aantal crisisplekken baseren we op verwachte vraag. Daarbij kijken we naar de bezettingsgraad van het afgelopen jaar. Hiervoor gebruiken we declaratiegegevens. Is een crisisplek naar verwachting minder dan 70% bezet? Dan verlagen we de afspraak tijdens herschikking. De inkoper bespreekt dit met u.

De bezettingsgraad berekenen we op basis van extrapolatie van de productierealisatie in de AW319. Declareer daarom altijd op de juiste crisisprestatie. Aangepaste afspraken gelden vanaf het moment van aanpassen. We passen afspraken niet met terugwerkende kracht aan. U garandeert beschikbaarheid tot het wijzigingsmoment. De afspraak voor jaar T geldt ook voor het jaar T+1.

Bent u een zorgaanbieder zonder afspraken over crisiszorg en wordt één van uw klanten opgenomen op een crisisplaats? Dan mag u gedurende de crisisplaatsing de reguliere zorg niet door declareren.

6.3 Implementatie van MGZ in alle regio's.

In de periode 2027–2029 werken we toe naar een volledige en blijvende invoering van Medisch-Generalistische Zorg (MGZ) in alle regio's. Dit sluit aan bij het Convenant Samenwerking MGZ. MGZ wordt daarmee een vast onderdeel van de eerstelijnszorg in de regio. Het is daarmee ook één van de thema's in de regionale opgave en wordt vastgelegd in de regionale overeenkomst. Ook voor nieuwe woonlocaties is voldoen aan het Convenant Samenwerking MGZ een randvoorwaarde, vóórdat een locatie wordt geopend.

Goede MGZ-dekking vraagt om nauwe samenwerking.

Een goede MGZ-dekking vraagt om nauwe en structurele samenwerking tussen betrokken partijen. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn een goede aansluiting op en samenwerking met de huisartsenzorg, ook bij spoed via de huisartsenpost (HAP). Daarnaast is veilige, tijdige en actuele digitale gegevensuitwisseling belangrijk. Ook kijken we naar een passende inzet van professionals, zoals de inzet van verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA).

De kern van het MGZ-kader is de basis op orde.

Dit betekent dat elke regio uiterlijk in 2029 beschikt over deze basiselementen voor MGZ. We zien daarbij toe op de totstandkoming, de actualisatie en de naleving ervan. De volgende onderdelen zijn hierbij belangrijk:

- Een regionaal afsprakenkader MGZ
- Structurele regionale governance
- Contractering en monitoring
- Melding en escalatie bij onvoldoende dekking

Een regionaal afsprakenkader MGZ.

Gebaseerd op het Convenant Samenwerking MGZ moet u het volgende borgen:

- **Huisartsenzorg:** U heeft afspraken met een vaste huisartsenpraktijk of een gelijkwaardig arrangement. Deze samenwerking ligt vast volgens het Convenant Samenwerking MGZ. De samenwerkingsovereenkomst komt overeen, of is vergelijkbaar, met de Samenwerkingsovereenkomst huisarts(praktijk) en (geclusterde) woonvoorziening of de Modelonderaannemingsovereenkomst Huisarts(praktijk) en zorgorganisatie van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Zo is voor iedereen duidelijk hoe de huisartsenzorg is georganiseerd en geborgd.
- **Inzet arts verstandelijk gehandicapten (AVG)/specialist ouderengeneeskunde (SO):** U heeft afspraken over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van een arts verstandelijk gehandicapten (AVG), volgens het Convenant Samenwerking MGZ. Als dat nodig is, heeft u ook afspraken met een specialist ouderengeneeskunde (SO). Ook maakt u wanneer nodig afspraken over (tijdelijk) medebehandelaarschap door de AVG en eventueel een SO.
- **ANW-bereikbaarheid en triage:** De avond-, nacht- en weekendzorg (ANW-zorg) is 24 uur per dag en 7 dagen per week geregeld. U maakt gebruik van de bestaande regionale voorziening. Er is altijd een verpleegkundige voorwacht met een geldige BIG-registratie. U heeft duidelijke afspraken over triage en uw woonlocatie is aangesloten bij de huisartsenspoedpost. Zo blijft medische zorg ook buiten kantooruren goed bereikbaar.
- **Informatie-uitwisseling:** U heeft duidelijke afspraken over het delen van gegevens. Het Huisartsen Informatie Systeem (HIS), het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) en, als dat speelt, het dossier van de AVG sluiten op elkaar aan. Daardoor is belangrijke medische en zorginhoudelijke informatie ook beschikbaar in de avond, nacht en in het weekend.

Structurele regionale governance.

Van aanbieders met een behandelrol verwachten we actieve deelname. Dit onder andere door het regionaal maken en onderhouden van MGZ-afspraken en het hanteren van een duidelijk escalatiemodel bij knelpunten.

Contractering en monitoring.

MGZ is vast onderdeel van regionale gesprekken en contractafspraken. Knelpunten worden actief gedeeld door de regio en/of zorgaanbieder en opgevolgd door het zorgkantoor en de zorgverzekeraar. De verantwoordelijkheden verschillen per zorgaanbieder. Dit hangt ervan af of een zorgaanbieder een eigen behandelorganisatie heeft of gebruikmaakt van externe afspraken voor MGZ.

Melding en escalatie bij onvoldoende dekking.

Het kan voorkomen dat het regionaal of lokaal niet lukt om een volwaardige MGZ te organiseren, ondanks aantoonbare inspanningen en de bereidheid om het convenant en het beleidskader volledig te volgen. In dat geval verwachten zorgkantoren dat u dit tijdig en actief bij ons meldt. Als regionale oplossingen onvoldoende zijn, kan het zorgkantoor dit landelijk escaleren, bijvoorbeeld via ZN of richting het ministerie van VWS.

6.4 We maken afspraken over plekken met en zonder behandeling.

Vanaf 2027 maken we op een andere manier afspraken over plekken met en zonder behandeling. Daarbij maken we onderscheid tussen afspraken voor VPT-zorg en afspraken voor zorg met verblijf.

VPT-zorg voor 3VG en 4VG is zonder behandeling.

Voor klanten met de profielen 3VG en 4VG spreken we alleen VPT-zorg zonder behandeling af. Heeft een klant tijdelijk Wlz-behandeling nodig? Dan kunt u extramurale behandeling inzetten naast het VPT tot maximaal de ruimte die de NZa-regels daarvoor bieden. Op deze manier zorgen we ervoor dat Wlz-behandeling ook beschikbaar is voor klanten op een plek zonder behandeling. Voor klanten met andere VPT-profielen maakt de zorgaanbieder een bewuste afweging of VPT met behandeling nodig en passend is.

We maken voor zorg met verblijf afspraken over plekken met behandeling.

De volumes zijn voor deze prestaties niet volledig persoonsvolgend. Het uitgangspunt is dat het aantal dagen met behandeling gelijk blijft. We spreken een vast aantal plekken met behandeling af voor alle VV- en GZ-verblijfprestaties. De afspraak voor 2027 baseren we op het aantal gedeclareerde en vergoede dagen in 2025. Heeft een klant op een plek zonder behandeling tijdelijk Wlz-behandeling nodig? Dan kunt u extramurale behandeling inzetten bovenop het ZZP tot maximaal de ruimte die de NZa-regels daarvoor bieden. Zo zorgen we ervoor dat Wlz-behandeling ook beschikbaar is voor klanten op een plek zonder behandeling.

6.5 We gaan in gesprek met levensloopaanbieders.

Het aantal klanten met een Wlz-indicatie dat wordt geïncludeerd in de [Levensloopaanpak](#) stijgt. Er is steeds meer zicht op de woonzorgbehoefte van deze groep klanten. De woonzorgbehoefte sluit niet goed aan bij het huidige zorgaanbod en er zijn onvoldoende plekken. Levensloopaanbieders geven aan dat landelijk voor ongeveer 40% van deze groep geen passende huisvesting is en voor bijna 30% deze huisvesting niet optimaal passend is. We zien de noodzaak om samen met u ander en meer aanbod voor deze doelgroep te organiseren en gaan over het benodigde aanbod ook met levensloopaanbieders in gesprek.

6.6 We willen aanbod realiseren met een hoog beveiligingsniveau (Salviq).

Landelijk werken de zorgkantoren samen met GZ- en GGZ-zorgaanbieders aan het realiseren van passend aanbod voor mensen met een intensieve langdurige ondersteuningsvraag én hoog beveiligingsniveau (Salviq). Het aanbod om deze groep mensen voor langere tijd in hun zorgbehoefte te voorzien is nu nog niet voorhanden, maar wel hard nodig. Mocht u dit aanbod kunnen leveren, dan gaan we graag met u in gesprek. In het [landelijke beleidskader Wlz \(pdf\)](#) vindt u meer informatie over het benodigde aanbod.

6.7 Het optimalisatie- en innovatiebeleid.

Zorgkantoren zien optimalisatie en innovatie als een cruciaal middel om de Wlz-zorg toekomstbestendig te houden voor klanten, medewerkers en maatschappij. De toenemende druk op toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit vraagt om een duidelijke strategie voor het opschalen van bewezen initiatieven (optimalisatie) en het ontwikkelen van nieuwe oplossingen (innovatie). Met als doel het verhogen van implementatie van in de praktijk bewezen initiatieven (optimalisatie) en versnelde en gerichte ontwikkeling van nieuwe innovaties. We maken daarbij onderscheid tussen:

- **Optimaliseren:** Inzetten van bewezen technologieën en werkwijzen. Wij verwachten van alle zorgaanbieders dat zij zich vanuit de reguliere financiering maximaal inzetten om te optimaliseren.
- **Innoveren:** Verkennen van nieuwe, nog onbewezen technologieën of werkwijzen. Dit doen we alleen samen met zorgaanbieders die daartoe in staat zijn.

Hierbij focussen we op de 6 thema's voor innovatie uit de landelijke inkoopvisie '[Visie op samenwerken aan langdurige zorg 2027-2029](#)' (pdf) en de inkoopdoelen uit dit inkoopbeleid.

We stimuleren de inzet van bewezen technologieën en werkwijzen.

Wij verwachten dat u:

- Op organisatie- of regio niveau een visie heeft op optimalisatie en de inbedding daarvan in alle lagen van de organisatie. In deze visie is voldoende aandacht voor de organisatie-specifieke randvoorwaarden die nodig zijn.
- Bij het kiezen van een leverancier of toepassing rekening houdt met regionale gegevensuitwisseling.
- Rekening houdt met databeschikbaarheid en digitale gegevensuitwisseling. Wetgeving (EHDS en Wegiz) verplichten zorgaanbieders tot elektronische uitwisseling van zorggegevens. Zo komt informatie over zorg sneller beschikbaar en is het risico op fouten kleiner.
- Voldoet aan de landelijke standaarden, zoals NEN7510. De implementatie hiervan vraagt om regionale afspraken, waarbij een Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO) kan ondersteunen. Wij verwachten aansluiting op Mitz voor toestemming en lokalisatie, het Zorg-adresboek voor adressering en Zorg-ID Smart (of een vergelijkbaar systeem) voor identificatie en authenticatie. Meer informatie over digitale gegevensuitwisseling vindt u op het [kennisplein op onze website](#).
- Voldoet aan de uniforme ambities voor zorginkoop, digitalisering en gegevensuitwisseling.

Een aantal toepassingen heeft zich inmiddels zo breed bewezen, dat wij verwachten dat alle zorgorganisaties deze toepassen:

- **Medicatie:** van fysiek aanreiken naar bijvoorbeeld een medicijn dispenser.
- **Rapportage:** van handmatig naar spraak gestuurd.
- **Oogdruppelen:** van hulp van een zorgverlener naar zelfstandig met een hulpmiddel.
- **Steunkousen:** van hulp van een zorgverlener naar zelfstandig met een hulpmiddel.
- **Begeleiding:** naar een combinatie van fysieke en digitale contactmomenten (bijvoorbeeld via beeldzorg).

Wij verwachten dat u deze toepassingen inzet bij alle klanten, als de toepassing past bij de zorgvraag. Alleen wanneer dit voor een individuele klant niet passend is, kan hiervan gemotiveerd worden afgeweken. Samen met u brengen we aan het begin van de beleidsperiode in beeld waar u staat ten opzichte van de inkoopdoelen, waar u in 2030 wilt staan en hoe optimalisatie daaraan bijdraagt. We delen inspirerende voorbeelden van succesvolle optimalisatie uit de praktijk. Deze vindt u op de pagina [Succesvolle initiatieven](#).

Waar nodig volgt het zorgkantoor de voortgang in de periodieke overleggen. Eventuele afspraken over voortgang of verbeteringen leggen we schriftelijk vast.

Voor zorg thuis met een MPT stimuleren we de inzet van thuiszorgtechnologie.

Thuiszorgtechnologie biedt mogelijkheden om zorg of toezicht op afstand te realiseren. We zien hierbij mooie nieuwe initiatieven. Alle zorgaanbieders die MPT leveren kunnen de inzet van thuiszorgtechnologie declareren via de bijbehorende prestaties en prestatiecodes. De totaal gedeclareerde zorg (inclusief thuiszorgtechnologie) moet binnen het budget dat bij de gestelde indicatie hoort vallen. Thuiszorgtechnologie moet tot substitutie van zorg leiden. Dat betekent dat thuiszorgtechnologie ter vervanging is van fysieke zorg of leidt tot uitstel van fysieke zorg. Zorgaanbieders kunnen de kosten declareren volgens de beleidsregel.

We innoveren gericht met een kleine groep zorgaanbieders.

Innoveren betekent het pionieren en ontwikkelen van een volledig nieuw product, dienst of zorgproces, die bijdragen aan duurzame veranderingen in de zorg. Zorgaanbieders onderzoeken de effecten van de innovatie en de randvoorwaarden om op te schalen. Het doel is dat succesvolle innovaties uiteindelijk onderdeel worden van optimalisatie en breed ingezet kunnen worden. Zorgaanbieders die innoveren voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De innovatie wordt samen ontwikkeld met minimaal één andere zorgaanbieder en/of maatschappelijke partner, zoals een gemeente, het onderwijs of werkgevers.
- De zorgaanbieder heeft een duidelijke visie op innovatie die aansluit bij de visie van het zorgkantoor.
- Het gaat om nieuwe, toekomstgerichte technologische of methodologische vernieuwing die nog niet breed beschikbaar is. En nog niet is vastgelegd in bestaande professionele standaarden.
- Er is nog geen uitgewerkte businesscase op basis van praktijkervaring en de effectiviteit van de innovatie moet nog verder worden onderzocht.
- De zorgaanbieder heeft voldoende capaciteit, mensen en slagkracht om innovatieve ideeën te ontwikkelen en succesvol in de praktijk te brengen.
- De zorgaanbieder heeft voldoende financiële middelen en is bereid te investeren in het onderzoeken van de innovatie.
- De zorgaanbieder is ambassadeur van het innovatietraject.

We willen innovatiekracht in de sector optimaal benutten en dubbel werk voorkomen. Daarom brengen de zorgkantoren samen meer focus aan. Zo voorkomen we dat er op meerdere plekken aan dezelfde innovatie wordt gewerkt. Samen met zorgaanbieders selecteren we potentieel baanbrekende innovaties. Zorgkantoren kunnen innovatietrajecten ondersteunen met kennis of capaciteit, op basis van een concreet plan en duidelijke afspraken.

6.8 Kwaliteitskader als uitgangspunt voor overleg over de kwaliteit van zorg.

Met het kwaliteitskader voor uw sector hebben we een gedeeld perspectief over de kwaliteit van de zorg om met u in gesprek te gaan. Klanten(raden) zijn in de gesprekken voor ons een vanzelfsprekende gesprekspartner. Om een goed beeld te krijgen van de door u geleverde zorg brengen we daarnaast ook de komende jaren bij veel zorgaanbieders regelmatig bezoeken op locatie. We hebben gemerkt dat dit een zinvolle aanvulling is op de gesprekken die we met u voeren.

6.9 U vult de Zorgatlas voor een actueel beeld van het beschikbare zorgaanbod.

Wij vinden het belangrijk dat klanten goed geïnformeerd worden over het beschikbare zorgaanbod. Voor onze klanten, naasten en verwijzers is de [Zorgatlas](#) beschikbaar, een online zoekmachine voor de langdurige zorg. Van alle gecontracteerde zorgaanbieders nemen we basisgegevens op in de Zorgatlas. U vult zelf in de Zorgatlas verdere gegevens van uw organisatie in en houdt deze actueel. Zo bent u beter vindbaar voor klanten die op zoek zijn naar passende zorg. Klanten kunnen via verschillende zoekcriteria informatie vinden over het beschikbare zorgaanbod in hun omgeving. Met de detailinformatie krijgen zij alvast een indruk van de locatie, bijvoorbeeld over de ligging en aanwezige voorzieningen.

Op onze [website](#) vindt u onder andere een handleiding van de Zorgatlas. Via deze pagina kunt u een beheerder aanmelden. Wij vragen u uw locaties zelf te voorzien van het actuele zorgaanbod en de locatiekenmerken. Zo werken we samen aan informatie voor klanten en hun naasten.

6.10 Doelmatige inzet van middelen.

De zorgvraag en kosten blijven groeien. Dit zet druk op de betaalbaarheid. Ook personeel en vastgoed zijn schaars. Daarom speelt doelmatigheid een rol bij al onze inkoopdoelen en realiseren we het inkoopbeleid dan ook binnen de financiële kaders en met een optimale inzet van middelen.

U declareert de best passende en meest doelmatige leveringsvorm.

Gelet op doelmatige inzet van middelen en het beperkte financiële kader is belangrijk dat u de best passende en meest doelmatige leveringsvorm declareert. Als een klant niet het volledige pakket aan zorg nodig heeft en/of een beperkt aantal uren, dan moet de zorg met [MPT prestaties gedeclareerd worden](#). In dit geval kunt u geen VPT declareren. We gebruiken spiegelinformatie die inzicht geeft in verschillen per zorgaanbieder tussen leveringsvormen. We gaan in gesprek met zorgaanbieders aan de hand van deze spiegelinformatie. Hiermee stimuleren we doelmatige inzet van beschikbare middelen.

Samenwerking maakt inzet van schaarse middelen doelmatiger.

Regionale samenwerking helpt om de schaarse middelen beter in te zetten. Zorgaanbieders organiseren voorzieningen samen, zoals essentiële voorzieningen en dagbesteding. Ook het samen inzetten op innovaties en arbeidsbesparende technologie is belangrijk. Dit draagt bij aan het verlagen van de klant/FTE ratio.

Verschillen in kosten van aanbieders bieden kansen voor verbetering.

We zien dat de opbouw van kosten en uitgaven tussen zorgaanbieders verschillen. Dit geeft mogelijkheden om de beschikbare middelen doelmatiger in te zetten. We willen u stimuleren te blijven werken aan het verbeteren van de doelmatigheid. Daarom ondersteunen we u met onze zorgaanbiederanalyse. Via spiegelinformatie faciliteren wij u met inzicht in uw kosten ten opzichte van andere zorgaanbieders. Deze informatie ondersteunt u bij de keuze op welke onderdelen u doelmatigheidsverbetering wilt realiseren. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.

We kunnen in gesprek gaan met zorgaanbieders over een hoog positief resultaat.

We vinden het belangrijk dat de schaarse middelen doelmatig ingezet worden, zodat alle klanten passende zorg krijgen. Daarom kunnen wij het initiatief nemen om in gesprek gaan met zorgaanbieders die, vergeleken met anderen, een hoog positief resultaat behalen. We vragen dan om een toelichting op dit resultaat en bekijken samen met de zorgaanbieder hoe het resultaat wordt ingezet en of lagere tariefpercentages mogelijk zijn.

6.11 Contracteren pgb wooninitiatieven.

Aansluitend op de visie van het kabinet vinden zorgkantoren dat een pgb alleen beschikbaar moet zijn voor klanten die daar bewust voor kiezen en niet als financieringsvorm. Wij zien dat sommige wooninitiatieven gefinancierd worden via een pgb maar feitelijk functioneren als zorg in natura. Om die reden zetten we in op het contracteren via zorg in natura (ZiN) van bestaande pgb -wooninitiatieven (dat wil zeggen: wooninitiatieven die reeds bestonden vóór 1 januari 2026). Voor deze contractering gelden de reguliere voorwaarden uit ons inkoopbeleid.

6.12 Vastgoed.

Goede gebouwen zijn belangrijk om nu en in de toekomst passende zorg te kunnen bieden. In de praktijk sluiten gebouwen niet altijd aan bij wat klanten en professionals nodig hebben. Daarom willen wij als zorgkantoor actief meedenken bij belangrijke keuzes over zorgvastgoed. Samen zoeken we naar oplossingen die werken in de praktijk en passen bij de toekomstige zorgopgave.

Grote keuzes over vastgoed vragen om zorgvuldige afstemming in de regio.

Nieuwbouw en grote verbouwingen hebben langdurige gevolgen en bepalen voor lange tijd waar en hoe zorg kan worden geleverd. Afstemming met relevante regionale partijen helpt om knelpunten voor klanten, medewerkers en de omgeving te voorkomen. We verwachten dat u plannen voor vastgoedinvesteringen in onze zorgkantoorregio's tijdig met ons bespreekt. Zo zorgen we er samen voor dat investeringen aansluiten bij de maatschappelijke opgave en dragen we bij aan toekomstbestendige zorg voor klanten.

De woonopgave is groot en vraagt gezamenlijke inzet.

Tot en met 2030 zijn bijna 300.000 extra woningen voor ouderen nodig. Ook in de gehandicaptenzorg (GZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) verwachten we dat de komende jaren meer mensen zelfstandig thuis wonen met passende zorg. Gezamenlijk richten wij ons op passende extramurale woon- en zorgarrangementen voor mensen die zorg thuis ontvangen.

We werken langs duidelijke actielijnen voor de extramurale woonopgave.

Vanuit het zorgkantoor werken wij aan de extramurale woonopgave via samenhangende acties:

- **Netwerkvorming:** wij stimuleren samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, marktpartijen en het zorgkantoor. Samen werken zij aan woonzorgvisies en uitvoeringsagenda's.
- **Van beleid naar praktijk:** wij voeren gesprekken met gemeenten en partners. Zo vertalen we woondealafspraken naar concrete locaties en plannen.
- **Monitoring en signalering:** wij volgen of de zorgvraag leidt tot voldoende woningen en passende woonvormen. Knelpunten signaleren we gezamenlijk.
- **Preventie en toekomstbestendig werken:** wij zetten in op initiatieven die Wlz zorgkosten voorkomen of beperken. Dit doen we onder andere via financiering volgens de Wet domeinoverstijgende samenwerking (DOS).
- **Kennisdeling:** wij delen goede voorbeelden en lessen uit de praktijk. Dit helpt om sneller stappen te zetten in de regio.

Iedere regio heeft trekkers nodig.

Wij verwachten dat zorgaanbieders in de regio actief bijdragen aan passende woon- en zorgarrangementen. Niet iedere aanbieder heeft dezelfde rol. Voor een goed werkend zorglandschap is het wel belangrijk dat er per regio aanbieders zijn die deze ontwikkeling dragen en verder brengen.

Wat we van u vragen.

Zorgaanbieders die hier een rol in kunnen spelen, dragen bij door:

- **Actief mee te doen in netwerken:** u neemt deel aan regionale en lokale netwerken voor wonen, zorg en welzijn en werkt mee aan gezamenlijke plannen.
- **Initiatief te nemen voor nieuwe woonvormen:** u ontwikkelt vernieuwende woonzorgconcepten, bijvoorbeeld met MPT, of VPT. Dit ondersteunt klanten om zelfstandig te blijven wonen.
- **Open te zijn over plannen:** u deelt uw plannen voor huisvesting en zorgcapaciteit. Dit maakt goede afstemming met gemeenten, woningcorporaties en andere partners mogelijk.

6.13 We gaan negatieve effecten van financiële constructies tegen.

Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden. Wij zien dat sommige zorgaanbieders via financiële constructies geld halen uit het zorgstelsel. Dit kan de zorg onnodig duur maken. Daarom verwachten wij van zorgaanbieders dat transacties met gelieerde partijen marktconform zijn. Denk aan leningen met een rente die past bij de markt en huurprijzen voor vastgoed die niet hoger zijn dan gebruikelijk. Dit betekent dat prijzen en voorwaarden moeten worden vastgesteld alsof sprake is van een transactie tussen onafhankelijke derden.

7. Planning en termijnen

Lees in dit hoofdstuk welke data belangrijk zijn. Zodat we met elkaar op tijd de afspraken voor het nieuwe jaar rond hebben. In de [Inkoopprocedure](#) lichten wij de stappen van de inkoopprocedure toe.

Uiterste datum	Stap	Wie
1 juni 2026	Bekendmaking van het inkoopbeleid Wlz-zorg 2027-2029	Zorgkantoor
15 juni 2026 12.00 uur	Mogelijkheid tot stellen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen	Zorgaanbieder
1 juli 2026	Publicatie van de Nota van Inlichtingen	Zorgkantoor
1 juli 2026	Openstellen inkoopapplicatie voor inschrijving	Zorgkantoor
21 juli 2026	Vervaltermijn voor kortgeding tegen het inkoopbeleid en de bijlagen	Zorgaanbieder
31 juli 2026 17.00 uur	Datum van inschrijving voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders	Zorgaanbieder
28 augustus 2026	Voorlopige terugkoppeling uitkomst van de beoordeling van de inschrijving	Zorgkantoor
4 september 2026	Publicatie definitieve vertrektarieven	Zorgkantoor
24 september 2026	Vervaltermijn voor bezwaar en kortgeding tegen: • publicatie van de definitieve vertrektarieven. • vervaltermijn voor bezwaar en kortgeding tegen terugkoppeling van de uitkomst van de inschrijving. • beroep op de hardheidsclausule.	Zorgaanbieder
2 oktober 2026	Als dat nodig is, een gesprek over contractering en voorwaarden	Zorgkantoor en zorgaanbieder
23 oktober 2026	Definitieve terugkoppeling inschrijving en aanbieden overeenkomst voor ondertekening	Zorgkantoor
30 oktober 2026	Uiterste datum voor indiening budgetformulier 2027 via NZa-portaal bij zorgkantoor	Zorgaanbieder
30 oktober 2026	Uiterste datum voor ondertekening overeenkomst in VECOZO	Zorgaanbieder
6 november 2026	Vervaltermijn voor kortgeding tegen de definitieve terugkoppeling	Zorgaanbieder
12 november 2026	Controle van ingediende budgetformulieren en doorzetting naar de NZa	Zorgkantoor
13 november 2026	Definitieve contractering en indiening budgetformulier bij NZa	Zorgkantoor en zorgaanbieder
1 juni 2027	Deadline aanvullende afspraken, waaronder afspraken in het kader van regionale ontwikkeling	Zorgkantoor en zorgaanbieder

8. Inkoopprocedure

In dit hoofdstuk leest u voor wie dit inkoopbeleid en de gehanteerde inkoopprocedure geldt en welke stappen daarbij horen. Ook leggen we stap voor stap uit hoe de contractering verloopt. Dit geldt zowel voor zorgaanbieders die in de vorige contractperiode al met ons samenwerkten, als voor zorgaanbieders die voor het eerst een contract met ons willen afsluiten.

8.1 De beginselen van de inkoopprocedure.

Zilveren Kruis gaat bij deze inkoopprocedure uit van de aanbestedingsrechtelijke beginselen, althans de precontractuele redelijkheid en billijkheid. Dit vullen wij in door de (procedure)regels die in de inkoopdocumenten, als ook in de Nota van Inlichtingen, zijn opgenomen. De beginselen van gelijkheid, transparantie en proportionaliteit brengen met zich dat de zorgkantoren op een transparante, niet-discriminatoire en proportionele wijze handelen in het kader van hun inkoopprocedures. Zilveren Kruis hecht er aan te benadrukken dat zij niet als aanbestedende dienst kwalificeert in de zin van de Aanbestedingswet 2012 of de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Dit inkoopbeleid is dan ook geen aanbestedingsprocedure zoals bedoeld in de betreffende aanbestedingsregelgeving. Verder liggen in de overeenkomst de rechten en verplichtingen van de zorgaanbieders en Zilveren Kruis vast.

8.2 Voor wie dit inkoopbeleid geldt.

Het inkoopbeleid geldt voor de elf regio's waarvoor Zilveren Kruis Zorgkantoor NV, verder te noemen Zilveren Kruis, namens alle Wlz-uitvoerders de Wlz verzorgt. Het inkoopbeleid is van toepassing voor alle zorgaanbieders in de GZ die Wlz-zorg in natura leveren aan klanten die wonen in één van onze zorgkantoorregio's:

- Amsterdam
- Apeldoorn/Zutphen e.o.
- Drenthe
- Flevoland
- Friesland
- 't Gooi inclusief Almere
- Kennemerland
- Rotterdam
- Utrecht
- Zaanstreek Waterland
- Zwolle

Het inkoopbeleid geldt voor alle leveringsvormen in Zorg in Natura: verblijf, VPT, MPT, DTV. Daarnaast is dit inkoopbeleid er ook voor zorgaanbieders die alleen behandeling leveren, zoals samenwerkingsverbanden van artsen verstandelijk gehandicapten (Arts VG) en specialisten ouderengeneeskunde (SO).

Dit inkoopbeleid vormt de basis en biedt een handleiding voor inschrijving voor een Wlz-overeenkomst met Zilveren Kruis voor 2027.

8.3 Er is een landelijke inkoopvisie en een landelijk beleidskader.

Alle zorgkantoren stelden gezamenlijk de landelijke inkoopvisie langdurige zorg op. Dit inkoopbeleid van Zilveren Kruis voor de GZ is een uitwerking van de [landelijke inkoopvisie \(pdf\)](#) voor alle zorgkantoorregio's van Zilveren Kruis en moet in samenhang met de landelijke inkoopvisie worden gelezen. De landelijke inkoopvisie inclusief bijlagen maken integraal onderdeel uit van dit zorginkoopbeleid en de overeenkomst Wlz 2027-2029 van Zilveren Kruis.

In het [landelijke beleidskader \(pdf\)](#) staan thema's die extra toelichting nodig hebben en onderwerpen waarvoor zorgkantoren samen één uniforme beleidslijn volgen. Daarnaast werkt het kader aanvullende voorwaarden en richtlijnen uit die zorgkantoren hanteren binnen de geldende wet- en regelgeving.

Bij tegenstrijdigheden gaat het inkoopbeleid van Zilveren Kruis voor.

De volgende rangorde geldt bij tegenstrijdigheden tussen verschillende documenten/delen, tenzij anders aangegeven:

1. Getekende Overeenkomst WLz die geldt voor 2027 (inclusief bijlagen)
2. Meest recente Nota's van Inlichtingen
3. Inkoopbeleid WLz Gehandicaptenzorg 2027-2029 (inclusief bijlagen)
4. Landelijk beleidskader (bijlage 2)
5. Landelijke inkoopvisie langdurige zorg (bijlage 1)

8.4 Tot 15 juni 2026 12 uur kunt u vragen stellen over het beleid.

Omdat wij weten dat een inkoopprocedure mogelijk om verduidelijking vraagt, bieden we de mogelijkheid om vragen te stellen over eventuele onduidelijkheden. Vanaf de publicatiedatum op 1 juni 2026 bent u tot uiterlijk 15 juni 2026 12.00 uur in de gelegenheid om vragen te stellen. Na deze sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om vragen te stellen over de teksten van het inkoopbeleid en bijbehorende documenten.

Zorgkantoren hebben hun proces om vragen te stellen in het kader van de Nota van Inlichtingen aangepast. U kunt uw vragen indienen via het [formulier](#). Alle zorgkantoren zijn aangesloten op het nieuwe digitale formulier. Alleen vragen die via dit formulier gesteld worden, nemen wij in behandeling.

Wij verwachten van deelnemers aan deze inkoopprocedure een proactieve houding.

U kunt alleen een rechtsgeldig beroep doen op onvolkomenheden, onduidelijkheden, vermeende onrechtmatigheden, tegenstrijdigheden of bezwaren die door uzelf, als individuele zorgaanbieder, uiterlijk 15 juni 2026 12.00 uur aan de orde zijn gesteld. Na deze sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om vragen te stellen over het inkoopbeleid en bijbehorende documenten.

Op 1 juli 2026 publiceren wij een Nota van Inlichtingen.

Daarin beantwoorden we de gestelde vragen. Veel voorkomende vragen zullen we niet letterlijk opnemen en beantwoorden, maar samenvoegen en van een antwoord voorzien. De gepubliceerde Nota van Inlichtingen prevaleert boven de inkoopdocumenten en maakt onderdeel uit van deze inkoopprocedure.

8.5 Er geldt een vervalt termijn voor een kortgeding over het inkoopbeleid.

Zorgaanbieders kunnen, als zij het niet eens zijn met het inkoopbeleid inclusief de gepubliceerde Nota van Inlichtingen binnen een termijn van 20 kalenderdagen na de dag van de publicatie van de Nota van inlichtingen een kortgedingprocedure beginnen bij de rechtbank te Den Haag. Deze termijn is een vervalt termijn. Door deelname aan de inkoopprocedure accepteren zorgaanbieders dat zij het kort geding aanhangig moeten maken binnen de termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van de Nota van Inlichtingen op straffe van verval van ieder recht om op een later moment tegen het inkoopbeleid inclusief de Nota van inlichtingen – in rechte – op te komen. Een eventueel aangespannen kortgeding heeft geen schorsende werking voor definitieve contractering.

8.6 De zorgkantoren kunnen de procedure wijzigen.

Zorgkantoren behouden zich het recht voor om een correctie in de documenten en/of een wijziging of aanpassing van de inkoopprocedure toe te passen, naar aanleiding van onvoorziene omstandigheden, gerechtelijke procedures of als na bekendmaking van deze documenten de overheid maatregelen treft die:

- van invloed zijn op de beschikbare contracteerruimte; of
- van invloed zijn op de afspraken die het zorgkantoor met zorgaanbieders op grond van deze maatregelen dient te maken; of
- een wijziging betreffen van de beleidsregels of een voortschrijdend inzicht op basis van ontwikkelingen in de zorg.

Aanpassingen aan de procedure kunnen divers zijn.

Zorgkantoren behouden zich het recht voor om op basis van bovenstaande zonder enige schadevergoedingsplicht de volgende aanpassingen te doen:

- Gehele of gedeeltelijke aanpassing of opschorting van het zorginkoopbeleid of aanpassing van de tariefpercentages – tussentijds, tijdelijk of definitief – om redenen die voor ons overtuigend zijn. Hieronder verstaan we mede externe omstandigheden als overheidsbeslissingen of gerechtelijke uitspraken.
- De procedure gedeeltelijk stoppen en het overige deel voortzetten.
- Het aanbrengen van wijzigingen in de procedure of in de aard en de omvang van de zorgprestaties die we inkopen.
- Het nemen van besluiten of treffen van maatregelen voor situaties die tijdens de publicatie van dit document niet bij ons bekend waren of die we niet konden voorzien.
- Het wijzigen van de tijdsplanning.

8.7 U schrijft in bij het zorgkantoor van de regio waarin u zorg levert.

Als zorgaanbieder schrijft u in bij die zorgkantoren die verantwoordelijk zijn voor de regio waarbinnen u zorg levert of wilt leveren. De fysieke locatie⁷ waar u zorg levert, bepaalt met welk zorgkantoor u een contract moet sluiten, op basis van de in die regio geldende inkoopvoorwaarden (inclusief tarief). In het grensgebied tussen zorgkantoren kunnen vraagstukken ontstaan. Wij vragen u dit bij de inschrijving aan te geven, zodat we tot een werkbare oplossing kunnen komen met elkaar.

8.8 Een juiste en volledige inschrijving.

Wij ontvangen van zorgaanbieders een inschrijving. We sluiten in principe één overeenkomst per zorgaanbieder. Deze overeenkomst kan voor verschillende regio's en sectoren gelden. U schrijft in op de sector die aansluit bij het landelijke cluster van de tariefsystematiek. Voor nieuwe zorgaanbieders geldt dat zij inschrijven op basis van het cluster wat het meest passend lijkt op basis van het ondernemingsplan. Het definitieve cluster voor nieuwe zorgaanbieders wordt in gesprek met de inkoper bepaald.

U schrijft in via het VECOZO zorginkoopportaal.

Inschrijvingen via andere kanalen behandelen wij niet en verklaren wij ongeldig. Met uw deelname gaat u akkoord met de voorwaarden uit het inkoopbeleid van Zilveren Kruis.

Nieuwe zorgaanbieders melden zich aan via het aanmeldformulier.

Bent u nieuw bij Zilveren Kruis? Dan geeft u via het [aanmeldformulier](#) aan dat u zich wilt inschrijven. Daarna ontvangt u van ons een instructie voor het inschrijfproces.

Wij ontvangen uw inschrijving uiterlijk 31 juli 2026 17.00 uur.

U dient uw inschrijving uiterlijk op 31 juli 2026 17.00 uur in via het [zorginkoopportaal](#) van VECOZO. Inschrijvingen na dit moment nemen wij niet in behandeling en sluiten wij uit van de inkoopprocedure. Na indienen ontvangt u een bevestiging van VECOZO. In dat bericht leest u ook hoe u de vragenlijst nogmaals kunt bekijken of kunt downloaden. Technische vragen over het zorginkoopportaal stelt u aan VECOZO of kijkt u na bij de veelgestelde vragen op hun [website](#).

Als de inschrijving van de zorgaanbieder wordt afgewezen n.a.v. de inschrijving uiterlijk 31 juli 2026 17.00 uur, heeft de zorgaanbieder geen mogelijkheid meer om opnieuw (tussentijds) in te schrijven voor het betreffende jaar (2027). Hij kan zich dan pas in de zomer van 2027 weer inschrijven om voor een overeenkomst voor 2028 in aanmerking te komen.

Wij behouden ons het recht voor om tussentijds nieuwe zorgaanbieders te contracteren als dit nodig is om aan de zorgplicht te kunnen blijven voldoen. Dit is enkel aan het zorgkantoor ter beoordeling en vindt uitsluitend plaats op initiatief van het zorgkantoor.

8.9 We maken onderscheid tussen bestaande en nieuwe zorgaanbieders.

In de procedure maken we onderscheid tussen de bestaande en nieuwe zorgaanbieders.

⁷ Hierbij gaat het om de feitelijke woonplaats van de klant en niet om het postadres van de klant. We maken hierop 2 uitzonderingen:

- Gespecialiseerde zorgaanbieders met een expertisefunctie. Denk hierbij aan Borg-instellingen, klinieken voor intensieve behandelingen en ZG-instellingen, of zorgaanbieders gespecialiseerd in epilepsiezorg. Dit geldt alleen voor de capaciteit verbonden aan de expertisefunctie. Bijvoorbeeld Borg-instellingen: alleen de SGLVG-behandelplaatsen behoren tot deze uitzondering, de andere plaatsen niet.
- Kleine woonlocaties in de GZ van 6 of minder personen met een Wlz-indicatie, tenzij de zorgaanbieder hier zelf om verzoekt.

Bestaande zorgaanbieder:

- Bestaand voor het zorgkantoor: zorgaanbieder die op het moment van inschrijven een overeenkomst heeft met het zorgkantoor waar ingeschreven wordt.
- Bestaand maar nieuw voor het zorgkantoor: zorgaanbieder die nieuw is voor het zorgkantoor waar ingeschreven wordt, maar op het moment van inschrijven al wel een overeenkomst heeft met ten minste één ander zorgkantoor voor minimaal het hele kalenderjaar 2026 en waarbij hij ten minste vanaf 1-1-2026 ook daadwerkelijk zorgkosten declareert.

Nieuwe zorgaanbieder:

- Zorgaanbieder die op het moment van inschrijven met nog geen enkel zorgkantoor een overeenkomst heeft.
- Zorgaanbieder die nieuw is voor het zorgkantoor waar ingeschreven wordt en op het moment van inschrijven al wel een Wlz-overeenkomst met een ander zorgkantoor heeft, maar niet voor het hele kalenderjaar 2026 of wel voor het hele kalenderjaar 2026 maar daarbij niet ten minste vanaf 1-1-2026 daadwerkelijk zorgkosten declareert. Een dergelijke zorgaanbieder is voor het zorgkantoor waar voor het eerst voor 2027 ingeschreven wordt, een nieuwe zorgaanbieder.

8.10 De eisen voor de inschrijving zijn afhankelijk van uw situatie.

1. U heeft een overeenkomst tot en met 31 december 2026 met het zorgkantoor waar ingeschreven wordt ('Bestaand voor het zorgkantoor' met een driejarige, tweejarige of éénjarige overeenkomst): bestuursverklaring.

U kunt volstaan met het indienen van een bestuursverklaring. Met de volledig ingevulde en ondertekende bestuursverklaring verklaart u dat uw organisatie vanaf de datum van inschrijving, tenzij anders is aangegeven, voldoet aan de daarin opgenomen eisen en dat u gedurende de looptijd van de overeenkomst aan die eisen blijft voldoen. Als zorgaanbieder verklaart u te voldoen aan geldende wet- en regelgeving, de gestelde geschiktheidseisen en de gestelde eisen aan onderaanneming. Ook geeft u in de bestuursverklaring aan dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Bovengenoemde zorgaanbieders hoeven bij de inschrijving naast de bestuursverklaring geen aanvullende documenten aan te leveren ter onderbouwing.

Als er wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de gegevens en/of (inschrijvings)documenten die ten grondslag lagen aan de laatste contracteringsronde, dan dient u deze wijzigingen te melden aan het zorgkantoor en de eventueel gewijzigde documenten aan te leveren. Zorgaanbieders moeten, ook wanneer er geen wijzigingen zijn, desgevraagd de onderbouwende stukken bij de bestuursverklaring aan het zorgkantoor kunnen overleggen. Wanneer zorgaanbieders van plan zijn nieuw zorgaanbod te ontwikkelen, kan hierop een toelichting worden gegeven bij de inschrijving.

2. U bent een bestaande zorgaanbieder en wilt met een voor u nieuw zorgkantoor een overeenkomst sluiten ('Bestaand maar nieuw voor het zorgkantoor'): bestuursverklaring en een ondernemingsplan.

Als u al een overeenkomst heeft met een zorgkantoor en u een overeenkomst wilt sluiten met een ander, voor u nieuw zorgkantoor en u voldoet aan de definitie van Bestaande zorgaanbieder in de zin van 'bestaand maar nieuw voor het zorgkantoor', dan levert u bij de inschrijving alleen de bestuursverklaring en een beknopt ondernemingsplan (tenminste het bedrijfs- en financieel plan) aan. Zie hiervoor ['Wat vragen wij van nieuwe zorgaanbieders \(pdf\)'](#). Het is niet nodig om informatie ter onderbouwing van de bestuursverklaring aan te leveren, omdat u al door een ander zorgkantoor bent gecontracteerd voor het leveren van Wlz-zorg. Zorgkantoren wisselen, indien nodig, onderling overige aanvullende informatie uit.

3. U bent een nieuwe zorgaanbieder: bestuursverklaring, een ondernemingsplan en documenten ter onderbouwing.

Bij de inschrijving moet de bestuursverklaring ingevuld worden. Daarbij moet voor een aantal items met documentatie aangetoond worden dat er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. Ook voor het ondernemingsplan geldt een verplichte opbouw van elementen. Lees welke documentatie er nodig is en welke voorwaarden gelden in ['Wat vragen wij van nieuwe zorgaanbieders \(pdf\)'](#).

8.11 Uw inschrijving heeft een meerjarig perspectief.

Met uw inschrijving en het ondertekenen van de bestuursverklaring stemt u in met het geschetste perspectief voor de zorginkoop voor de komende 3 jaar. In het hoofdstuk [Wat willen we bereiken](#) leest u welke doelen we met het

zorginkoopbeleid willen realiseren en op welke wijze we dit samen met u willen doen. De kaders van het zorginkoopbeleid zijn hiermee voor het komende jaar helder.

Sluit u per 2027 een meerjarenovereenkomst dan kunt u voor inschrijving voor de opvolgende jaren volstaan met een instemmingsverklaring.

8.12 Nieuwe zorgaanbieders moeten een leemte in het zorgaanbod vervullen.

We contracteren alleen zorgaanbieders die een inhoudelijke bijdrage leveren aan het toekomstbestendige zorglandschap. Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat nieuwe zorgaanbieders het aanbod in zorg in natura verrijken. Nieuwe zorgaanbieders kunnen vernieuwing brengen en inspringen op vraagstukken in de regio of specifieke klantvragen- of wensen. Tegelijkertijd zijn te veel nieuwe en vooral kleine zorgaanbieders een risico voor versnippering van het zorglandschap en bemoeilijkt dit de regionale samenwerking. Daarom is het belangrijk dat nieuwe zorgaanbieders een duidelijke rol hebben in de regio en aantoonbare meerwaarde bieden ten opzichte van het bestaande zorgaanbod. Daarom houden we bij de beoordeling en toelating van nieuwe zorgaanbieders hier nadrukkelijk rekening mee.

Nieuwe zorgaanbieders kunnen in aanmerking komen voor een overeenkomst als zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan alle gestelde voorwaarden én:

- zich onderscheiden van andere zorgaanbieders, en
- een duidelijke leemte in het zorgaanbod vullen, bijvoorbeeld voor een specifieke doelgroep of bij een tekort in de regio, en
- door hun omvang of rol een wezenlijke bijdrage leveren aan de regionale opgave en samenwerking.

8.13 Minimale omvang voor een overeenkomst.

Levert u op het moment van inschrijving zorg aan minder dan 10 Wlz klanten⁸ in de zorgkantoorregio waarvoor u inschrijft? En is uw omzet lager dan € 150.000? Dan komt u in principe niet in aanmerking voor een overeenkomst. Deze omvang is te klein voor een zelfstandige overeenkomst. Wij adviseren u dan om te verkennen of er andere mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld het leveren van zorg in onderaannemerschap, het samenwerken met een andere partij of het aansluiten bij een zorgcoöperatie. Bent u op dit moment onderdeel van een zorgcoöperatie of werkt u als onderaannemer? Dan motiveert u de meerwaarde van een zelfstandige overeenkomst met het zorgkantoor. Zo begrijpen wij uw keuze beter.

8.14 Nieuwe zorgaanbieders moeten voldoen aan alle voorwaarden.

Naast het voldoen aan de sectorale kwaliteitseisen en de juridische voorwaarden die in dit inkoopbeleid staan, verwachten wij van nieuwe zorgaanbieders dat zij belangrijke zorginhoudelijke en administratieve randvoorwaarden goed op orde hebben. Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat ook nieuwe zorgaanbieders goed hebben nagedacht over deze randvoorwaarden en deze hebben geborgd. Het gaat om:

- Het sluiten van samenwerkingsafspraken in de regio, dan wel het aansluiten bij relevante samenwerkingsverbanden.
- Het borgen van de MGZ voor hun klanten.
- Het borgen van de benodigde Wlz specifieke behandeling voor hun klanten.

Nieuwe zorgaanbieders leveren de gevraagde documentatie aan.

Het is van belang dat uw inschrijving volledig is en u alle gevraagde [documenten \(pdf\)](#) bij de inschrijving aanlevert. Als een nieuwe zorgaanbieder een ondernemingsplan indient dat incompleet is en/of niet volledig voldoet aan beschreven eisen, dan kan het zorgkantoor besluiten de zorgaanbieder van verdere deelname aan de inkoopprocedure uit te sluiten of anders te prioriteren, afhankelijk van de aard en omvang van de tekortkoming. Dit geldt ook voor bestaande zorgaanbieders maar nieuw voor het zorgkantoor die een beknopt ondernemingsplan (tenminste het bedrijfs- en financieel plan) moeten aanleveren.

⁸ Voor zorgaanbieders die op het moment van inschrijving zorg in pgb leveren spreken we af dat er per 1-1-2027 minimaal 10 klanten zijn die gebruik maken van Zorg in Natura.

8.15 In sommige gevallen is een aanvullende toelichting nodig.

Dit is het geval bij de inzet van onderaannemers en/of een verandering in bestuurlijke structuur.

Zorgaanbieders melden hun onderaannemers.

Wij verwachten dat zorgaanbieders tenminste 2/3 van de productie zelf leveren (dat wil zeggen met personeel dat in loondienst is) en maximaal 1/3 van de verwachte gecontracteerde zorg door onderaannemers⁹ laten leveren. Wij willen weten welke onderaannemers actief zijn en voor welk deel van de productie zij ingezet worden. Als u met onderaannemers werkt, bent u verplicht deze bij de inschrijving te melden. Vult u voor het melden van onderaannemers de [tabel in de bestuursverklaring \(xlsx\)](#) in.

Nieuwe onderaannemers moet u tussentijds melden.

Dit doet u voorafgaand aan de inzet van de onderaannemer door een e-mail te sturen naar contractadministratiewlz@zilverenkruis.nl. Bij deze melding levert u de [tabel voor onderaannemers uit de bestuursverklaring \(xlsx\)](#) opnieuw ingevuld aan. In de e-mail vermeldt u duidelijk welke onderaannemer(s) nieuw zijn toegevoegd ten opzichte van de eerder gemelde situatie. U krijgt van ons binnen twee weken een reactie op uw melding.

De zorgaanbieder die een onderaannemer inzet voor zorglevering blijft altijd volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg door de onderaannemer. De zorglevering door de onderaannemer moet dan ook aan alle eisen voldoen die het zorgkantoor aan de zorglevering van de hoofdaannemer stelt. Het is daarnaast niet toegestaan om een ZZP- of VPT-pakket volledig door een onderaannemer te laten leveren, tenzij het zorgkantoor daar schriftelijk toestemming voor geeft.

8.16 Wij beoordelen uw inschrijving.

We gebruiken een vaste beoordelingsprocedure. Bij de beoordeling van zorgaanbieders voeren we de volgende beoordelingsstappen uit:

1. Controle op volledigheid van de inschrijving;
2. Controle van hetgeen is verklaard in de bestuursverklaring en, indien van toepassing, beoordeling van de bij de inschrijving gevoegde documenten;
3. Nieuwe zorgaanbieder en bestaande zorgaanbieder maar nieuw voor het zorgkantoor: mogelijk een inhoudelijk gesprek, bij voorkeur op locatie van de zorgaanbieder.

Alleen met een juiste en volledige inschrijving komt u voor een overeenkomst in aanmerking.

Wij bekijken na sluiting van de inschrijving of de inschrijving volledig en juist is. Onvolledige inschrijvingen worden niet beoordeeld, bijstelling en aanvulling op initiatief van de zorgaanbieder is niet toegestaan. Een inschrijving is volledig wanneer:

- De bestuursverklaring is aangeleverd, én;
- Alle [onderbouwende documenten \(pdf\)](#) bij de inschrijving zijn bijgevoegd, én;
- Eventuele onderbouwende documenten, zoals vereist in het regionale beleid, zijn ingevuld, dan wel bijgevoegd.

Wij hebben de bevoegdheid tot het vragen van een toelichting.

Zorgkantoren hebben na inschrijving de bevoegdheid (maar niet de verplichting) om een zorgaanbieder te vragen zijn inschrijving toe te lichten. De zorgaanbieder heeft dan vijf werkdagen de tijd om de gevraagde toelichting aan te leveren bij het zorgkantoor. Hierna kan de inschrijving definitief worden beoordeeld. Aan het enkel vragen om een (nadere) toelichting door het zorgkantoor kunnen geen rechten of toezeggingen worden ontleend.

Wij controleren de aangeleverde documenten.

Als de inschrijving volledig is, controleren wij wat de bestuurder heeft verklaard over zijn organisatie in de bestuursverklaring. Het gaat niet alleen om controle van wat is ingevuld in de bestuursverklaring, maar ook om beoordeling en controle van de documenten die nieuwe zorgaanbieders (maar ook [bestaande zorgaanbieders maar nieuw voor het zorgkantoor](#)) ter onderbouwing moeten aanleveren. In deze periode beoordelen wij bij nieuwe zorgaanbieders ook het aangeleverde ondernemingsplan.

⁹ Voor de definitie van onderaanneming verwijzen wij naar de overeenkomst.

Een integriteitstoets kan deel uitmaken van de beoordeling.

Wij kunnen hiervoor bij de inschrijving voor ons relevante informatie bij u opvragen. De integriteitstoets is een verantwoordelijkheid van het zorgkantoor en bevat een toets op de uitsluitingscriteria. Een VOG RP die het Ministerie van Veiligheid en Justitie afgeeft, kan deze integriteitstoets niet vervangen, maar is als aanvulling daarop bedoeld.

Samengevat nemen we uw inschrijving niet in behandeling of sluiten we deze uit in de volgende gevallen:

- Inschrijvingen die niet via de digitale inkoopapplicatie zijn ingediend.
- Inschrijvingen die niet tijdig zijn aangeleverd.
- Onvolledige inschrijvingen.
- Inschrijvingen die onjuiste en/of valse informatie bevatten.
- Als u niet voldoet aan één of meer van de gestelde geschiktheidseisen of overige eisen (bekijk [bijlage 4A 'Bestuursverklaring' \(pdf\)](#)).
- Als één of meer van de uitsluitingsgronden (bekijk [bijlage 4A 'Bestuursverklaring' \(pdf\)](#)) op u van toepassing is/zijn.
- Als er geen positieve uitkomst is van een door het zorgkantoor ingesteld onderzoek bij gerezen twijfel, de twijfel of een zorgaanbieder de inschrijving volledig dan wel gedeeltelijk kan waarmaken.

8.17 Een inhoudelijk gesprek met nieuwe zorgaanbieders.

Met zorgaanbieders die in 2027 nieuw zijn voor Zilveren Kruis en die voldoen aan de [voorwaarden \(pdf\)](#) gaan wij in september 2026 in gesprek. Ook de aangeleverde informatie over het te leveren zorgaanbod en de omvang van de zorgaanbieder nemen wij mee in de keuze om wel of niet over te gaan tot een gesprek. Wij maken graag kennis met nieuwe zorgaanbieders, bij voorkeur op de locatie van de zorgaanbieder. In een gesprek willen we een beter beeld krijgen van de drijfveren, bestuurders en de organisatie achter het ondernemingsplan. In het gesprek toetsen we of het beeld van de zorg en de toelichting van de directie/bestuurder consistent is met het ondernemingsplan en of u aan alle voorwaarden voldoet. Ook toetsen we expliciet op de [inhoudelijke criteria](#) en of sprake is van vervullen van een [leemte](#) om in aanmerking te komen voor zelfstandige contractering. Er is gelegenheid om in te gaan op afspraken over de te leveren prestaties. De uitkomsten van het gesprek nemen we mee in de definitieve beoordeling. Pas na het gesprek besluiten we definitief of we een overeenkomst voor 2027 aan gaan.

Wij beoordelen of u een overeenkomst krijgt.

Of nieuwe zorgaanbieders een overeenkomst krijgen aangeboden, wordt beoordeeld door Zilveren Kruis. In deze laatste fase van de beoordeling kunnen onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende redenen tot afwijzing van nieuwe zorgaanbieders leiden. Het eindoordeel hierover is aan Zilveren Kruis:

- Een onvoldoende transparante bestuursstructuur;
- Het geoffreerde aanbod onderscheidt zich niet van dat van andere zorgaanbieders. De zorgaanbieder draagt niet bij aan de opvulling van en leemte in de regio t.a.v. specifiek zorgaanbod en levert geen wezenlijke bijdrage aan de regionale opgave
- Een negatief eigen vermogen of financieel slechte positie;
- Het ondernemingsplan is onvoldoende toekomstbestendig, reëel of haalbaar;
- Beoordeling van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar aanleiding van het bezoek (onder andere) in het kader van de melding op grond van de Wtza dat de basiskwaliteit niet op orde is en/of onvoldoende vertrouwen in verbetering op korte termijn;
- Afspraken over samenwerking in de regio en/of de keten zijn niet of onvoldoende geborgd;
- MGZ zorg, dan wel Wlz specifieke behandeling is niet of onvoldoende geborgd;
- Bevindingen op basis van de integriteitstoets;
- Eén of meerdere gegronde klachten bij zorgkantoor en/of zorgverzekeraar die ernstig van aard waren en waarover in het gesprek geen lerend effect duidelijk werd gemaakt;

- Het beeld vanuit het gesprek met bestuurder(s) en het bezoek op locatie is niet consistent met het ondernemingsplan en niet vertrouwenwekkend.

8.18 Wij geven een terugkoppeling op uw inschrijving.

Uiterlijk 28 augustus 2026 koppelen wij op basis van de uitkomsten van onze beoordeling terug of wij voornemens zijn een overeenkomst aan te gaan voor 2027 en welke afspraken we met u willen maken. Aan dit voornemen kunt u geen rechten ontleen. Wanneer wij in onze beoordeling geen bijzonderheden constateren, zijn wij voornemens om met de volgende zorgaanbieders de volgende overeenkomsten aan te gaan:

- Bestaande zorgaanbieders in de zin van 'bestaand voor het zorgkantoor', die het hele aan 2027 voorafgaande jaar een overeenkomst hebben gehad, komen in aanmerking voor een overeenkomst voor drie jaar (2027-2029) met de mogelijkheid voor het zorgkantoor om de overeenkomst eenzijdig twee keer met een periode van één jaar te verlengen.
- Bestaande zorgaanbieders in de zin van 'bestaand voor het zorgkantoor' die een overeenkomst voor een deel van het aan 2027 voorafgaande jaar hebben gehad, komen in aanmerking voor een overeenkomst voor één jaar (2027).
- Bestaande zorgaanbieders in de zin van 'bestaand maar nieuw voor het zorgkantoor' komen in aanmerking voor een overeenkomst voor één jaar (2027);
- Nieuwe zorgaanbieders komen in aanmerking voor een eenjarige overeenkomst (2027).

8.19 We kunnen het inkoopbeleid Wlz 2027-2029 verlengen naar 2030 en 2031.

Dit meerjarenbeleid bevat de mogelijkheid voor Zilveren Kruis om het zorginkoopbeleid tweemaal met een jaar te verlengen voor 2030 en 2031.

8.20 We kunnen ontbindende voorwaarden aan de overeenkomst verbinden.

Op basis van onze beoordeling van de situatie bij een zorgaanbieder (waaronder maar niet uitsluitend lopende onderzoeken materiële controle of onderzoeken toezichthouders zoals IGI) hebben wij de mogelijkheid om (ontbindende) voorwaarden te verbinden aan het aangaan van een overeenkomst. Zorgaanbieders die voor 2026 een overeenkomst onder voorwaarden hebben met Zilveren Kruis of waarbij er gedurende 2026 bevindingen zijn die daar aanleiding toe geven, krijgen niet als vanzelfsprekend een overeenkomst voor 2027. Met deze partijen gaan wij eerst het gesprek aan. Als er sprake is van een vermoeden – al dan niet op basis van de uitkomsten van materiële controles – van fraude door de betreffende zorgaanbieder en hiernaar een onderzoek loopt of reeds bevindingen zijn gedaan, kunnen we besluiten om met de betreffende zorgaanbieder geen overeenkomst te sluiten. Ook kan alsnog uitsluiting of ontbinding volgen, in het geval een overeenkomst al is gesloten. Hetzelfde geldt wanneer uit een (NZa) onderzoek blijkt dat de administratie niet op orde is, er fraude is gepleegd of een IGI-maatregel is opgelegd.

8.21 Uiterlijk 4 september publiceren wij de definitieve vertrektarieven.

Deze vertrektarieven zijn gebaseerd op de laatst beschikbare jaarverslagen. Meer informatie leest u in de paragraaf [Een landelijk tariefmodel met vertrektariefpercentage als uitgangspunt](#).

8.22 Vervaltermijn voor kortgeding tegen de tarieven en terugkoppeling.

Zorgaanbieders kunnen, als zij het niet eens zijn met onze beslissing om al dan niet een overeenkomst te sluiten dan wel over looptijd of voorwaarden, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na de dag van de voorlopige terugkoppeling een kortgedingprocedure beginnen bij de rechtbank te Den Haag. Deze termijn is een vervaltermijn. Zorgaanbieders kunnen daarbij niet opkomen tegen zaken die al eerder aan de orde gesteld hadden kunnen en moeten worden. Deze vervaltermijn geldt ook voor het bezwaar tegen de onderbouwing van de beslissing over de definitieve vertrektarieven. In een dergelijk geval zullen wij geen beroep doen op rechtsverwerking ten aanzien van bezwaren gericht tegen (de onderbouwing van) de vertrektarieven. Als evenwel bezwaar wordt gemaakt op gronden die al in rechte beoordeeld zijn zonder dat sprake is van een wijziging van feiten of omstandigheden, is wel sprake van verval van recht en staat het ons vrij om de bezwaren met verwijzing naar de desbetreffende rechterlijke beslissing (kennelijk) ongegrond te verklaren. Door deelname aan de inkoopprocedure accepteren zorgaanbieders dat zij een bezwaar moeten maken en/of een kort geding aanhangig moeten maken binnen de termijn van 20 kalenderdagen na datum van publicatie van de definitieve vertrektarieven en na de datum van voorlopige terugkoppeling op straffe van verval van ieder recht om op een later moment tegen de beslissing over de

definitieve vertrektarieven en onze voorgenomen beslissing om al dan niet een overeenkomst te sluiten – in rechte – op te komen. Een eventueel aangespannen kortgeding heeft geen schorsende werking voor definitieve contractering. Let op: het is niet mogelijk om na sluiting van de inschrijving alsnog bewijsmiddelen aan te leveren die verplicht bij de inschrijving moeten worden ingediend, tenzij het zorgkantoor daarom heeft verzocht.

8.23 U kunt een beroep doen op de hardheidsclausule.

Overweegt u om een beroep te doen op de [hardheidsclausule](#)? Neemt u dan contact op met uw zorginkoper. Uw zorginkoper bespreekt met u de reden van het beroep. Voor de aanvraag dient u gebruik te maken van een standaard aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier is gemaakt om de informatie op te halen die noodzakelijk is voor de beoordeling van uw aanvraag. Het is belangrijk dat u dit formulier juist en volledig invult, zodat wij een goed beeld hebben van uw (toekomstige) financiële situatie. U kunt het aanvraagformulier opvragen via het e-mailadres zorginkoopwlv@zilverenkruijs.nl. Hierin leest u welke informatie u dient aan te leveren.

Als u een beroep doet op de hardheidsclausule, stuurt u het ingevulde aanvraagformulier op via zorginkoopwlv@zilverenkruijs.nl en uw zorginkoper. U benoemt daarbij de term “hardheidsclausule” expliciet in het onderwerp van uw bericht. U kunt het aanvraagformulier indienen na bekendmaking vertrektarief, uiterlijk op 24 september 2026. Wij adviseren u het aanvraagformulier voor 8 september 2026 in te leveren. Zo heeft u de mogelijkheid om ontbrekende informatie aan te vullen of correcties te maken zodat uiteindelijk een volledig en juist aanvraagformulier wordt ingediend. Uw zorginkoper geeft aan wanneer dit het geval is.

Afhankelijk van de situatie kunnen we aanvullende documenten opvragen. De afspraken over de hardheidsclausule zijn geldig voor maximaal de duur van het betreffende inkoopjaar.

Als na indiening van de stukken de NZa-tarieven worden bijgesteld, dan zal het zorgkantoor de omzet op dezelfde manier bijstellen als dat de NZa-tarieven zijn bijgesteld.

Wij geven uiterlijk 23 oktober 2026 een terugkoppeling op uw aanvraag voor de hardheidsclausule. Als achteraf blijkt dat een verleende hardheidsclausule niet nodig blijkt dan wordt de toekenning van de hardheidsclausule teruggedraaid.

Bij deerschikking en/of nacalculatie zullen wij controleren of de zorgaanbieder die afspraken heeft op grond van de hardheidsclausule daar nog steeds voor in aanmerking komt. Als dan blijkt dat de zorgaanbieder geen beroep meer toekomt op de hardheidsclausule (bijvoorbeeld omdat zijn financiële situatie gedurende het jaar is verbeterd) maakt Zilveren Kruis aanspraak op het bedrag (of een gedeelte daarvan) dat aan de zorgaanbieder is betaald op grond van de hardheidsclausule.

8.24 De prestaties die we afspraken in 2026 vormen de basis voor 2027 en verder.

Voor zorgaanbieders die al bij ons bekend zijn, gebruiken we de prestaties waarover ook in 2026 afspraken zijn gemaakt, als basis voor de afspraken in 2027. Het gaat om de prestaties die u tot en met augustus 2026 heeft gedeclareerd.

Wij hebben alle Wlz-prestaties naar sector, grondslag en leveringsvorm ingedeeld naar ‘regulier’ en ‘specifiek’. Dit is inzichtelijk gemaakt in [Bijlage 8 \(xlsx\)](#). Hierin kunt u zien welke prestaties wij nadrukkelijk toetsen of beperkt inkopen. Voor het openstellen van prestaties is altijd vooraf toestemming nodig van de zorginkoper. Deze toetst onder meer of u aan alle gestelde voorwaarden voldoet om de prestatie open te stellen. Wanneer u in 2027 nieuw zorgaanbod wilt leveren, bijvoorbeeld een nieuwe leveringsvorm of zorg in een andere zorgkantoorregio, meldt u dit bij uw zorginkoper. Uw zorginkoper gaat hierover met u in gesprek.

Met nieuwe zorgaanbieders spreken we standaard de reguliere prestaties af behorend bij de sector, grondslag en leveringsvorm op basis van de inschrijving en het ondernemingsplan en een kennismakingsgesprek.

8.25 U kunt in gesprek met uw inkoper.

Een gesprek over contractering en voorwaarden met de zorginkoper is mogelijk. Zorgaanbieders en zorginkopers zijn gedurende het jaar met elkaar in gesprek. Het voeren van een ‘inkoopgesprek’ is daarom niet altijd noodzakelijk. De zorginkoper bepaalt op basis van uw inschrijving of een inkoopgesprek noodzakelijk is en in welke vorm.

8.26 U ontvangt een definitieve terugkoppeling.

Uiterlijk 23 oktober 2026 ontvangt u de definitieve terugkoppeling van uw inschrijving. Wij sturen u een terugkoppeling met, indien van toepassing, de volgende 3 documenten:

1. De overeenkomst Wlz 2027, voorzien van eventuele voorwaarden en gemaakte afspraken voor zover dat laatste op dat moment mogelijk is.
2. De vastgestelde initiële afspraak 2027. Hierin staan de definitief overeengekomen prestaties en afspraken over het tariefpercentage en/of volume voor 2027.
3. Een e-mail met een toelichting op de overeenkomst en de initiële afspraak.

8.27 U kunt een kortgeding starten tegen de definitieve terugkoppeling.

Zorgaanbieders kunnen, als zij het niet eens zijn met onze beslissing, binnen een termijn van 14 kalenderdagen, nadat zij schriftelijk zijn geïnformeerd over de definitieve terugkoppeling een kortgedingprocedure beginnen bij de rechtbank te Den Haag. Deze termijn is een vervaltermijn. Door deelname aan de inkoopprocedure accepteren deelnemers dat zij een kort geding aanhangig moeten maken binnen de termijn van 14 kalenderdagen nadat zij schriftelijk zijn geïnformeerd over de definitieve terugkoppeling op straffe van verval van ieder recht om op een later moment tegen de voorgenomen vaststelling van onze beslissing – in rechte – op te komen. Een eventueel aangespannen kortgeding heeft geen schorsende werking voor het verdere verloop van de inkoopprocedure voor overige deelnemers. Ten overvloede merken wij op dat deelnemers geen bezwaar kunnen maken tegen zaken die al eerder aan de orde gesteld hadden moeten en kunnen worden.

8.28 Uiterlijk 13 november 2026 zijn alle afspraken definitief.

Hiervoor accepteert u uiterlijk 30 oktober 2026 de overeenkomst en de initiële afspraak via het VECOZO-portaal. Tegelijkertijd stelt u de ondertekende budgetformulieren beschikbaar in het NZa-portaal, zodat wij deze kunnen beoordelen.

In het budgetformulier leggen we geen prijs en volume vast.

In het budgetformulier leggen we geen afspraken vast over prijs en volume. Dit past bij ons uitgangspunt van [persoonsvolgende bekostiging](#). De NZa vraagt wel om een omzetniveau op te nemen. Daarom vullen wij in het budgetformulier een omzet van € 1 in. Dit houdt het administratieve proces eenvoudig. Ook geeft het opnemen van een historische omzet géén garantie over de financiering. In de herschikking leggen wij het definitieve financiële kader voor u vast.

De afspraken over de te leveren prestaties en de bijbehorende tariefpercentages leggen we vast in een bijlage bij de overeenkomst. Met ons betaalbeleid zorgen we voor continuïteit van zorg bij de overgang tussen jaren.

Na akkoord dienen wij het budgetformulier uiterlijk 12 november 2026 in bij de NZa.

Wij wijzen u erop dat er geen overeenkomst tot stand komt als de getekende overeenkomst en de vastgestelde initiële afspraak voor 2027 ontbreken. In dat geval behouden wij ons het recht voor om geen budgetformulier bij de NZa in te dienen. De overeenkomst komt pas tot stand nadat de overeenkomst en de initiële afspraak zijn ondertekend én het wij het budgetformulier bij de NZa hebben ingediend.

9. Verantwoording, sturing en nacalculatie

In dit hoofdstuk leest u hoe wij samen met u sturen op verantwoorde Wlz-zorg. We volgen of afspraken worden nageleefd, hoe beschikbare middelen worden ingezet en of de geleverde zorg past bij de zorgvraag van de klant. Ook leest u hoe wij met spiegelinformatie, monitoring, herschikking en nacalculatie zicht houden op kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid. Zo weet u wat wij van u verwachten.

9.1 Algemene uitgangspunten voor naleving.

U levert zorg volgens de geldende richtlijnen, protocollen en veldnormen. Ook de kwaliteitskaders van uw sector zijn van toepassing. Het kan voorkomen dat voor één zorgaanbieder meerdere kwaliteitskaders gelden. Wij volgen of de gemaakte afspraken worden nageleefd. In gesprekken en via controles bekijken we of u handelt volgens de overeenkomst en dit zorginkoopbeleid. Ontvangen wij signalen dat afspraken mogelijk niet worden nagekomen? Dan gaan wij hierover met u in gesprek.

Soms is aanvullende informatie nodig om de situatie goed te beoordelen. In dat geval kunnen wij u vragen om extra informatie aan te leveren. Ook kunnen wij een materiële controle uitvoeren. Dit is een controle waarbij we nagaan of de geleverde zorg en de declaraties met elkaar in overeenstemming zijn.

Zorgkantoren nemen maatregelen als daar aanleiding toe is.

Blijkt tijdens de looptijd van de overeenkomst dat u afspraken niet nakomt of dat u niet voldoet aan de voorwaarden? Of staat de kwaliteit van zorg of de financiële positie onder druk? Dan nemen we passende maatregelen. Welke maatregel we inzetten, hangt af van de situatie. Als dat nodig is, betrekken wij ook andere partijen, zoals de IGJ.

In de overeenkomst staat welke maatregelen het zorgkantoor kan nemen als afspraken niet worden nageleefd. Deze opsomming is niet uitputtend. Dat betekent dat ook andere passende maatregelen mogelijk zijn.

9.2 Monitoring en informatievoorziening.

U meldt grote veranderingen van uw productie op tijd aan ons. Dit doet u actief en vooraf, zowel bij een verwachte stijging als daling. Zo krijgen wij beter inzicht in de ontwikkeling van vraag en aanbod. Dit helpt ons om goede prognoses te maken, kosten beter in te schatten en zicht te houden op wat er in de regio gebeurt. Bij verwachte veranderingen kunnen wij u vragen naar de reden.

U ziet elke maand de verwachte benutting van de contracteerruimte.

Wij [publiceren](#) elke maand de verwachte benutting van de contracteerruimte en de actuele publicatieplanning. Deze publicatie is vooral gebaseerd op de AW319-gegevens over de betreffende periode. We rekenen de gerealiseerde productie door naar een jaarbasis. Zo ziet u of deze past binnen de beschikbare contracteerruimte van uw sector. Ook vermelden we steeds het bijbehorende procentuele risico.

Op deze manier krijgt u inzicht in de benutting van de contracteerruimte per sector en in het risico op de financiering van de geleverde zorg in dat jaar. In onze communicatie besteden we hier expliciet aandacht aan.

Daarnaast reserveren we een deel van de contracteerruimte voor meerzorg. Zo kunnen we de ontwikkeling van de kosten voor meerzorg goed volgen en, als dat nodig is, op tijd aanvullende beleidsmaatregelen nemen.

Uw reactie helpt ons vooruit te kijken.

Elke 2 maanden sturen we u een overzicht ter indicatie. Daarin ziet u op basis van de nieuwste declaratiecijfers hoe hoog uw afspraak bij de herschikking van dat jaar zou zijn. Ook staan de betalingen erin die we tot dan toe hebben verwerkt. We vragen u om op deze monitor te reageren. Met uw reactie zien we verwachte tekorten eerder aankomen en kunnen we u beter informeren.

9.3 Tussentijds herschikken.

Vaste afspraken blijven zo lang mogelijk uit. Zo kunnen we de keuze van de klant blijven volgen. Ook krijgt u ruimte om te ondernemen. Of we later toch overgaan naar vaste productieafspraken, hangt onder meer af van de kwaliteit van de aangeleverde declaraties en van de stand van de contracteerruimte in dat jaar. Komen er naar verwachting extra financiële middelen beschikbaar, zoals herverdelingsmiddelen? Dan nemen we die mee in ons besluit.

Het geld-volgt-klantmodel stopt niet meteen.

Bij een verwachte overschrijding van de contracteerruimte per sector zetten we het geld-volgt-klantmodel niet direct om naar vaste productieafspraken. In plaats daarvan laten we maandelijks zien over welk deel van de te leveren productie u een mogelijk financieringsrisico loopt. Ook volgen we nauwkeurig of omzetting naar productieafspraken nodig is.

Bij meer dan 1% onzekerheid kunnen we tussentijds herschikken.

Dreigt de procentuele onzekerheid over de financiële waarde van de geëxtrapoleerde gerealiseerde productie groter te worden dan 1%? Dan is ons uitgangspunt dat we het volledige geld-volgt-klantmodel omzetten naar productieafspraken. Dit noemen we een tussentijdse herschikking. Met het stellen van dit maximale risicopercantage geven we u meer duidelijkheid. Ook willen we zo risico's voor de continuïteit van zorg beperken. Daarbij blijft ons uitgangspunt dat we zorg zo veel mogelijk financieren. Vóór 1 juni van een kalenderjaar zetten we afspraken binnen het geld-volgt-klantmodel niet snel om. Dat doen we ook niet als er een verwacht tekort is van meer dan 1%. De reden is dat de beschikbare cijfers en de contracteerruimte dan nog veel onzekerheid kennen.

U hoort het als afspraken veranderen bij de publicatie van zorgkosten.

Gaan we over naar vaste productieafspraken? Dan laten we dat weten bij de publicatie van de zorgkosten. We baseren deze afspraken op de goedgekeurde geëxtrapoleerde productie van de maand waarover de gepubliceerde zorgkosten gaan. In de extrapolatie nemen we het bijbehorende onzekerheidspercentage en andere financiële afspraken, bijvoorbeeld voor regionale ontwikkeling mee. Wanneer hier sprake van is informeren we u over de vaste productieafspraken voor uw organisatie.

Een tussentijdse herschikking geeft duidelijkheid over een deel.

Met een tussentijdse herschikking krijgt u duidelijkheid over het deel van uw productie waarvoor wij naar verwachting een herschikkingsafpraak kunnen maken. De financiering van de gedeclareerde productie boven deze afspraak blijft dan onzeker. Pas bij de definitieve herschikking kunnen wij aangeven of we deze productie alsnog kunnen omzetten in afspraken. Zorg die u levert boven de (tussentijdse) herschikkingsafpraak komt in principe niet voor vergoeding in aanmerking.

9.4 Herschikken.

In de loop van ieder kalenderjaar maken we met u definitieve productieafspraken. Dat doen we via de definitieve herschikking. De herschikking vindt plaats binnen de contracteerruimte die de NZa aan ons toekent.

Zo stellen wij de herschikkingsafspraken vast.

Bij de herschikking volgen we de keuze van de klant. Eerst leggen we toezeggingen vast die we eerder deden, bijvoorbeeld over complexe casuïstiek en regionale ontwikkeling. Daarna bepalen we de productieafpraak voor crisiszorg. Dat doen we op basis van de verwachte bezettingsgraad en gemaakte afspraken. Tot slot stellen we de herschikkingsafpraak vast op basis van de geëxtrapoleerde, goedgekeurde en gedeclareerde AW319-productie over 2026. De AW319 is de periodieke declaratie- en productie-informatie.

In de herschikking extrapoleren wij op basis van goedgekeurde declaraties.

Wij nemen daarin de volgende punten mee:

- Zien we in de AW319-gegevens duidelijke trends, positief of negatief? Dan houden we daar rekening mee in de extrapolatie.
- Is de extrapolatie van de zorg met verblijf met behandeling hoger dan het afgesproken aantal dagen zorg met verblijf met behandeling? Dan passen wij een correctie toe.

Zijn de middelen per sector niet toereikend? Dan passen we een onzekerheidspercentage toe op de geëxtrapoleerde productierealisatie van dat jaar.

Het is mogelijk dat de afspraak in de definitieve herschikking lager is dan de afspraak bij een eventuele tussentijdse herschikking.

De peildatum bepaalt de productieafspraken.

Voor de definitieve productieafspraken gebruiken we de goedgekeurde declaratiegegevens uit de AW319 van het betreffende kalenderjaar. We gebruiken daarvoor uw goedgekeurde declaraties tot en met juni op peildatum 1 augustus van elk jaar als de basis voor de herschikking.

De procedure staat uiterlijk medio juli klaar.

In de herschikkingsprocedure delen we de definitieve planning voor de herschikking. Daarin staan onder meer de peildatum en de maand die we gebruiken voor de extrapolatie. U leest daar ook hoe het afstemmen van de herschikkingsafspraken verloopt. We actualiseren deze procedure ieder jaar. Deze vindt u op onze [website](#).

Naar verwachting moeten de definitieve productieafspraken uiterlijk 30 oktober van het betreffende jaar bij de NZa zijn ingediend. Om dat op tijd te doen, voeren we de herschikking in dat geval in september uit. We doen dit het liefst zo laat mogelijk in het jaar. Zo sluiten we zo goed mogelijk aan op de actuele keuzes van klanten.

Nieuwe zorgaanbieders krijgen bij de herschikking een maatwerkafspraken.

We begrijpen dat het tijd kost om uw weg te vinden binnen de Wlz. We begrijpen ook dat het krijgen van klanten soms tijd kost. Daardoor vormen de eerste maanden van declareren binnen de Wlz soms geen goede basis voor de herschikking. Daarom maken we voor nieuwe zorgaanbieders een best mogelijke inschatting voor een realistische definitieve productieafspraken voor het betreffende jaar. Daarbij houden we rekening met uw situatie.

9.5 Nacalculatie.

De nacalculatie sluit aan op de herschikking. Na afloop van ieder kalenderjaar stelt de NZa de aanvaardbare kosten per zorgaanbieder definitief vast. Dit heet de nacalculatie. Daarbij vormen de gerealiseerde productie en de overige kosten, die passen binnen de herschikkingsafspraken, het uitgangspunt. Hieronder vallen ook de vastgelegde financiële afspraken voor regionale ontwikkeling.

De nacalculatieprocedure publiceren we uiterlijk 31 december 2027 op [onze website](#). In deze procedure leest u de definitieve planning en de werkwijze voor de nacalculatie.

Wij corrigeren het verschil tussen zorg met verblijf met en zonder behandeling.

Wanneer bij onze nacalculatie blijkt dat het aantal gedeclareerde dagen zorg met verblijf met behandeling afwijkt van de afgesproken dagen, passen wij hier een correctie op toe. Wij gaan daarbij uit van de afspraak dat het totaal aantal dagen verblijf met behandeling gelijk blijft. Als zorg met verblijf met behandeling is ingezet boven de afgesproken afspraak, nemen wij deze extra dagen niet volledig mee in de definitieve productie. Dit betekent dat deze zorg niet volledig wordt vergoed.

Verrekening binnen 1 concern is mogelijk.

Wij staan positief tegenover verzoeken om onderproductie en overproductie binnen 1 concern met elkaar te verrekenen. Dit kan gaan om 1 concern met overeenkomsten bij 1 of meer zorgkantoren. Het is uw verantwoordelijkheid dat de bedragen in de nacalculatie gelijk zijn. Wij stellen de definitief te verrekenen bedragen binnen het concern pas vast na controle van de nacalculatie over het betreffende kalenderjaar. Dat doen we omdat er nog correcties kunnen volgen.

Bijlagen

Alle bijlagen bij het inkoopbeleid kunt u [downloaden](#) op onze website. Daar vindt u de volgende bijlagen.

Overzicht bijlagen:

- Bijlage 1 - Landelijke Inkoopvisie – Visie op samen werken aan langdurige zorg 2027-2029
- Bijlage 2 - Landelijk beleidskader Wlz 2027
- Bijlage 3A - Overeenkomst Wlz 2027-2029
- Bijlage 3B - Overeenkomst Wlz 2027
- Bijlage 4A - Bestuursverklaring Wlz 2027
- Bijlage 4A - Bijlage opgave onderaannemers bij bestuursverklaring
- Bijlage 5 – Declaratieprotocol Wlz 2027
- Bijlage 6 - Voorschrift zorgtoewijzing Wlz 2027 (*volgt in december*)
- Bijlage 7 - Onderbouwing vertrektarieven Wlz 2027
- Bijlage 7a - Leveringsvorm prestaties 2025 Wlz
- Bijlage 7c - Uitvraagformat Wlz declaratiedata 2025
- Bijlage 8 - Prestatietabel Regulier - Specifiek – Tariefpercentages 2027
- Bijlage 9 – Betaalbeleid 2027
- Bijlage 10 - Overzicht Gericht Contracteren GZ 2027